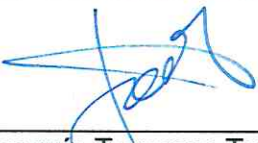
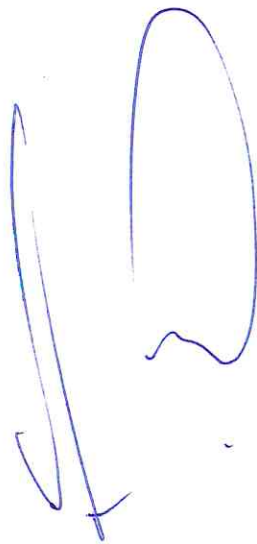
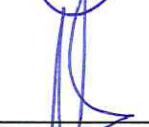
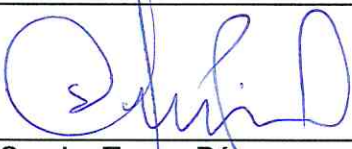


		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 1 de 153	

Manual de Fármacos Inyectables

Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Joaquín Troncoso Torres Enfermero UPC Adulto	 Flor Acuña Aravena Supervisora de Unidad de Paciente Crítico Adulto	
 Evelyn Guzmán Espinoza Enfermera UPC Adulto	 Rosana Sepúlveda Ancamil Supervisora de Centro de Responsabilidad de Paciente Crítico	
 Nayareth Flores Fierro Enfermera UPC Adulto	 Sandra Torres Pérez Químico Farmacéutico UCI Adultos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 2 de 153	

Elaboradores versiones anteriores del documento:

Versión	Fecha elaboración	Elaboradores

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 3 de 153	

Índice

1.- Introducción.....	9
2.- Objetivos.....	9
a). - Objetivo General:	9
b). - Objetivos Específicos:	10
3.- Alcance.	10
4.- Excepción.....	10
5.- Responsables	10
6.- Documentación de Referencia.	11
7.- Definiciones o Glosario.....	12
8.- Desarrollo.	16
1.- ACICLOVIR.....	16
2.-ÁCIDO TRANEXAMICO	17
3.- ÁCIDO VALPROICO	18
4.- ADENOSINA	19
5.- ADRENALINA (EPINEFRINA)	20
6.- ALBUMINA 20 %.....	21
7.- AMIKACINA.....	22
8.- AMINOÁCIDOS 10%.....	23
9.- AMINOFILINA	24
10.- AMIODORONA	25
11.-AMPICILINA.....	26
12.- AMPICILINA – SULBACTAM.....	27
13.- ANFOTERICINA B DEOXCILATO	28
14.- ANFOTERICINA B LIPOSOMAL	29
15.- ANIDULAFUNGINA	30
16.- ATRACURIO BESILATO	31
17.- ATROPINA SULFATO 1 %.....	32
18.- AZITROMICINA	33

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 4 de 153	

19.- BASILIXIMAB	34
20.- BETAMETASONA	35
21.- BICARBONATO DE SODIO 8,4%	36
22.- BROMURO DE ROCURONIO	37
23.- BUPIVACAINA.....	38
24.- ESCOPOLAMINA	39
25.- CASPOFUNGINA	40
26.- CALCIO GLUCONATO 10 %	41
27.- CEFAZOLINA	42
28.- CEFEPIME	43
29.- CEFOPERAZONA - SULBACTAM	44
30.- CEFOTAXIMA.....	45
31.- CEFTAZIDIMA - AVIBACTAM	46
32.- CEFTAZIDIMA	47
33.- CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM	48
34.- CEFTRIAXONA	49
34.- CEFUROXIMA	50
36.- CIPROFLOXACINO	51
37.- CLINDAMICINA	52
38.- CLORFENAMINA MALEATO	53
39.- CLONIXINATO DE LISINA	54
40.- CLORPROMAZINA.....	55
41.- CLOXACILINA.....	56
42.- COLISTIMETATO SODICO	57
43.- CLORURO DE SODIO 10 %	58
44.- CLORURO DE POTASIO 10 %	59
45.- COTRIMOXAZOL (TRIMETROPRIM – SULFAMETOXAZOL).....	60
46.- DANTROLENO.....	61
47.- DAPTOMICINA.....	62

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 5 de 153	

48.- DESMOPRESINA	63
49.- DEXAMETASONA.....	64
50.- DEXMEDETOMIDINA	65
51.- DIAZEPAM.....	66
52.- DOBUTAMINA	67
53.- DICLOFENACO SODICO	68
54.- DOMPERIDONA.....	69
55.- DOPAMINA	70
56.-DROPERIDOL	71
57.- EFEDRINA 6%.....	72
58.- ERGOMETRINA MALEATO.....	73
59.-ERTAPENEM	74
60.- ETOMIDATO	75
61.- FENILEFRINA 1%	76
62.- FENITOINA SODICA.....	77
63.- FENOBARBITAL.....	78
64.- FENOTEROL	79
65.- FENTANILO.....	80
66.- FILGRASTIM.....	81
67.- FITOMENADIONA	82
68.-FLUCONAZOL	83
69.-FLUMAZENIL	84
70.- FUROSEMIDA	85
71.- FOSFATO MONOPOTÁSICO 15%	86
72.- GAMAGLOBULINA HUMANA	87
73.- GENTAMICINA.....	88
74.- HALOPERIDOL	89
75.- HEPARINA	90
76.- HIDROCORTISONA.....	91

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 6 de 153	

77.- HIDROXILO FERRICO EN COMPLEJO C/SACAROSA	92
78.- IMIPEMEN + CILASTATINA	93
79.- INSULINA NPH	94
80.- INSULINA RÁPIDA.....	95
81.- ISOPROTERENOL	96
82.- KETAMINA.....	97
83.- KETOPROFENO	98
84.- KETOROLACO	99
85.- LABETALOL.....	100
86.- LANATOCIDO C.....	101
87.- LEVETIRACETAM.....	102
88.- LEVOFLOXACINO	103
89.- LIDOCAINA 2%.....	104
90.- LIDOCAINA HIPERBARICA 5%	105
91.- LINEZOLID	106
92.- LORAZEPAM.....	107
93.- MEROPENEM	108
94.- METADONA.....	109
95.- METAMIZOL	110
96.- METILPREDNISOLONA SUCCINATO	111
97.- METOCLOPRAMIDA.....	112
98.- METRONIDAZOL.....	113
99.- MIDAZOLAM	114
100.- MILRINONA.....	115
101.- MORFINA	116
102.- NALOXONA	117
103.- MULTIVITAMINICO HIDROSOLUBLE	118
104.- MULTIVITAMÍNICO LIPOSOLUBLES.....	119
105.- NEOSTIGMINA.....	120

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 7 de 153	

106.- NITROGLICERINA	121
107.- NITROPRUSIATO	122
108.- NOREPINEFRINA	123
109.- OLIGOELEMENTOS.....	124
110.- OCTREOTIDE	125
111.- OMEPRAZOL.....	126
112.- ONDANSETRON	127
113.- OXITOCINA	128
114.- PARGEVERINA 5 MG/METAMIZOL 2G	129
115.- PARACETAMOL.....	130
116.- PENICILINA G SODICA	131
117.- PETIDINA.....	132
118.- PIPERACILINA - TAZOBACTAM	133
119.- PIRIDOXINA.....	134
120.- PROPANOLOL	135
121.- PROPOFOL.....	136
122.- PROTAMINA.....	137
123.- RANITIDINA.....	138
124.- SODIO BICARBONATO 2/3 MOLAR	139
125.- SUCCINILCOLINA.....	140
126.- SULFATO DE MAGNESIO 25 %	141
127.- TERLIPRESINA.....	142
128.- TIAMINA	143
129.- TIGECICLINA	144
130.- TRAMADOL	145
131.- VANCOMICINA	146
132.- VECURONIO.....	147
133.- VERAPAMILO.....	148
134.- VORICONAZOL.....	149

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 8 de 153	

135.- URAPIDIL.....	150
7. Distribución.	151
8. Registro.....	151
9. Control de cambios.	151
10. Anexos.	152
Anexo 1: Fórmulas de cálculo	152
Anexo 2: Equivalencias.....	153
I.- Equivalencias de masa y volumen.....	153
II. - Equivalencias de electrolitos.....	153

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 9 de 153	

1.- Introducción

La complejidad de la medicina actual y los avances en los cuidados de los pacientes hacen necesario revisar los procesos de atención y estandarizar los cuidados, logrando de esta manera disminuir al mínimo los riesgos en nuestros procedimientos. Un área muy relevante pero poco valorada es la preparación y administración de medicamentos, la que debe ser protocolizada con la finalidad de unificar criterios que aporten seguridad a los cuidados de nuestros pacientes.

La estandarización del cuidado facilita el quehacer profesional, permitiendo una mejor organización laboral, se unifican criterios y aumentan los índices de calidad, siendo de gran impacto y beneficio para el usuario.

El presente manual busca aportar y ayudar a mejorar la calidad en la atención del paciente hospitalizado, garantizando la seguridad en el proceso realizado por el profesional.

Para su desarrollo y elaboración se realizó una minuciosa revisión bibliográfica y creación de fichas técnicas para cada medicamento, contando con la participación de un equipo multidisciplinario (enfermeras clínicas y químico farmacéutico).

La información contenida en este manual no excluye la consulta al Servicio de Farmacia o a otras fuentes de información siempre que sea necesario. Debemos recordar que puede existir un mismo medicamento con diferentes marcas, lo que hace necesario revisar la información que aporta el laboratorio fabricante. Como es un procedimiento de calidad, no fue posible anexar las marcas de los medicamentos revisados.

Se aconseja consultar al Servicio de Farmacia cualquier duda que surja en la interpretación de la información entregada en el Manual.

2.- Objetivos

a). - Objetivo General:

Estandarizar la atención de salud referente al manejo de fármacos inyectables en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 10 de 153	

b). - Objetivos Específicos:

- Unificar los criterios de dilución y administración de fármacos inyectables.
- Fortalecer conocimientos farmacológicos del profesional de salud.
- Minimizar los eventos adversos asociados a la administración del tratamiento inyectable.
- Facilitar y optimizar el uso adecuado de recursos.
- Facilitar información al personal de enfermería

3.- Alcance.

Este manual debe ser de conocimiento de todos los funcionarios que tengan participación en el manejo y administración de los fármacos inyectables en los distintos servicios clínicos donde se lleven a cabo estos procedimientos.

4.- Excepción.

Este manual hace referencia a aquellos fármacos incluidos en el arsenal de medicamentos hospitalario y excluye a la mayor parte de los fármacos que están protocolizados en otros documentos institucionales, de manera de evitar doble información y errores de interpretación. Los fármacos que aun así están incluidos se mantuvieron las indicaciones ya establecidas.

5.- Responsables

Todo personal de salud que participe en la administración de fármacos inyectable:

Médico tratante, es responsable de la indicación de tratamiento (dosis, horario y vía de administración). En casos particulares son responsables de administrar fármacos específicos.

Enfermero(a) y/o matron(a) clínico(a), es responsable de la administración de medicamentos por vía endovenosa periférica y central, además de otras vías inyectables (intramuscular, subcutánea).

Técnico paramédico, esta actividad puede ser delegada en casos excepcionales, pero debe ser siempre supervisada por enfermero o matron.

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 11 de 153	

6.- Documentación de Referencia.

- Volumen de dilución de fármacos intravenosos en pacientes con restricción de fluidos B. Proy Vega¹, E. Domingo Chiva², C. García Gómez¹, M. Hernández Sansalvador³ y E. M. García Martínez.
- The Renal Drug Handbook, Third Edition. Caroline Ashley and Aileen Currie have asserted their right under the Copyright. Designs and Patents Act 1998 to be identified as the authors of this work. First Edition 1999, Second Edition 2004.
- Minimum Infusion Volumes For fluid restricted critically ill patients, Fourth Edition, 4th Edition (v4.4) December 2012 Kashani A, Landaverde C, Medici V, Rossaro L. Fluid retention in cirrhosis: pathophysiology and management. QJM. 2008, Feb;101(2):71-85.
- Ministerio de salud. Guía clínica infarto agudo del miocardio con supradesnivel del segmento st. Santiago: Minsal, 2010.
- Manual de Medicamentos Endovenosos de Unidad de Paciente Crítico del Hospital de Niños, Dr. Exequiel González Cortés
- Manual de preparación y administración de medicamentos inyectables utilizados en el Hospital Clínico Universidad de Chile, elaborado por Carolina Figueroa L.: Alumna en Práctica Q.F. Lorena Brito F.: Q.F. Jefe Dispensación de Farmacia del Hospital Clínico Universidad de Chile. Nancy Abusada A.: Q.F. Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universidad de Chile. Año de Edición: 2007.
- Guías prácticas para el manejo del dolor agudo. Sociedad de anestesiología de Chile, Año 2003.
- Guía Clínica Alivio del dolor por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos. 1st Ed. Santiago: Minsal, 2005.
- Guías clínicas y recomendaciones de la unidad de farmacia del Hospital Luis Calvo Mackena. Marzo, 2006.
- Practice guidelines for acute pain management in preoperative setting. Anesthesiology , 2004; 100:1573-81.
- Recomendaciones para el manejo de dolor agudo en niños. Sociedad de Anestesiología de

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 12 de 153	

Chile, 2007.

- <http://www.drugs.com> , Internet database. Acceso Enero 2018 a Mayo 2019.
- <http://www.micromedexsolutions.com> , Internet database. Acceso Enero 2018 a Mayo 2019.
- <http://www.vademecum.es> , Internet database. Acceso Enero 2018 a Mayo 2019.
- <http://www.calvomackenna.cl> , Internet database. Acceso Enero 2018 a Mayo 2019.
- <http://www.aemps.gob.es> , Internet database. Acceso Enero 2018 a Mayo 2019.

7.- Definiciones o Glosario.

El Manual fue diseñado con fichas de resumen para entregar la siguiente información:

Nombre del medicamento y clasificación: Se presenta el nombre del fármaco, además se muestra en la siguiente línea el grupo farmacológico al que pertenece.

Presentación: Se describen la presentación en mg y/o volumen disponible en el arsenal.

Indicación: Patología o condición clínica en que está indicada la administración del fármaco.

Contraindicación: Condición clínica en la que debe evitarse el uso del fármaco.

Almacenamiento: Condiciones de conservación en la unidad de destino final.

Estabilidad: Tiempo y condiciones de almacenamiento, pudiendo ser a temperatura ambiente o refrigerada entre 2 a 8 ° C; en el que el medicamento mantiene su estabilidad química y farmacológica, luego de ser reconstituido o diluido. Debe considerarse la normativa de infecciones intrahospitalarias para el manejo microbiológico por contaminación de las soluciones, el cual es de 24 horas y que puede diferir con el del fármaco, pudiendo ser más o menos tiempo.

Sueros compatibles: Se especifican los medios compatibles en los cuales los medicamentos pueden ser reconstituidos o diluidos. Si la presentación del fármaco no requiere reconstitución ni dilución, como es el caso del matraz, se determinará como NO APLICA.

Reconstitución: Preparación con el solvente adecuado y recomendado del fármaco que contiene polvo liofilizado o polvo estéril para su posterior administración.

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 13 de 153	

Dilución: Cantidad de solvente en que se debe diluir un medicamento, para ser administrado. La indicación de solvente (mg) por solución (ml) es la recomendada y pudiera cambiar según la condición clínica y patológica del paciente. Su administración será para uso vía periférica y de ser necesario será indicado la forma de uso vía central.

Administración: Se describen las distintas formas seguras de poder usar el fármaco, entre los cuales están: endovenoso directo (bolo), endovenoso intermitente, endovenosos continuo (bomba de infusión continua), intramuscular y otras vías (subcutánea, intratecal, epidural, etc).

EV directa: Administración del medicamento tal como viene presentado, pudiéndose inyectar el contenido de la ampolla o el vial reconstituido directamente en la vena o bien en el punto de inyección que disponen los equipos de administración. La administración debe ser lenta, como mínimo en 1- 2 minutos en unos casos y en 3-5 minutos en otros.

EV infusión intermitente: Durante un periodo de tiempo limitado, en un plazo máximo de 2 horas y un pequeño volumen de líquido (generalmente entre 50-250 ml). La infusión intermitente, se recomienda cuando uno de los medicamentos requiere una cantidad específica de dilución, en pacientes con limitación en la administración de líquidos o en medicamentos que su estabilidad se altera si se administra durante un tiempo prolongado.

EV infusión prolongada: administración de un medicamento, por un plazo mayor a dos horas y menor a 24 horas.

EV infusión continua: Se refiere a la administración del medicamento en un período de tiempo asignado, generalmente mantenida durante 24 horas. La infusión continua pretende mantener la concentración plasmática constante del medicamento, se utiliza con medicamentos que precisan altas dosis.

IM: La inyección intramuscular es una forma de administración rápida en la que el medicamento es inyectado directamente dentro de un músculo.

Otras vías: Se refiere a las otras distintas opciones de administración de los medicamentos, pudiendo ser vía subcutánea, vía intratecal, entre otras.

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 14 de 153	

Velocidad de Administración: Se especifica la cantidad y el tiempo en el que el fármaco debe de ser administrado según su vía.

Dializable: Hace referencia a si el fármaco es o no factible de ser dializado por terapias convencionales y no convencionales. Esto permite deducir la necesidad de sugerir su refuerzo y así lograr que su efecto se lleve a cabo. Será definido como SI o NO. Si no hay información disponible se indicara SIN DATOS.

Observaciones y Reacciones adversas (RAM): Recomendaciones, advertencias y otros datos que se deben tener en cuenta, antes o durante la administración del medicamento. Efectos indeseables producidos en el paciente, luego de la administración de un medicamento.

Incompatibilidades: Reacción indeseable que puede ocurrir entre el fármaco y la dilución, el envase o con otro fármaco. Los dos tipos de incompatibilidad asociadas a la administración endovenosa son físicos y químicos.

Abreviaturas

AM	Ampolla	MG/ ML	Miligramos por mili litro
FA	Frasco Ampolla	KU/ ML	10.000 unidades por mili litro
FAL	Frasco Ampolla Liofilizado	U/ ML	Unidad por mili litro
MTZ	Matraz	G/ ML	Gramos por mili litro
SF	Suero fisiológico 0.9%	ML/ HR	Mili litro por hora
SGL	Suero glucosalino	MG/HR	Mili gramo por hora
SG5%	Suero glucosado 5%	G/HR	Gramo por hora
SRL	Suero ringer lactato	G/ KG/MIN	Gramo por kilo gramo por minuto
API	Agua para inyectable	G/KG/ HR	Gramo por kilogramos por hora
VR	Vía rectal	MG/KG/ MIN	Mili gramo por kilogramo por minuto
JER	Jeringa	MG/ KG/ HR	Mili gramo por kilogramo por hora
Hrs	Horas	UG/ KG/MIN	Gamma por kilogramo por minuto
Min	Minutos	UG/ KG/HR	Gamma por kilogramo por hora

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 15 de 153	

Gr	Gramos	UG/HR	Gamma por hora
IM	Intramuscular	UG/MIN	Gamma por minuto
IV	Intravenosa	U/ HR	Unidad por hora
EV	Endovenosa	U/ MIN	Unidad por minuto
SC	Subcutáneo	KU/MIN	Kilo unidad por minuto
Kg	Kilogramo	KU/HR	Kilo unidad por hora
M	Molar	KU	Kilo unidad (10.000 unidades)
mEq	Miliequivalente	UG	Gama
MEq/L	Miliequivalente por litro	Mcg	Microgramo
mg	Miligramo	1 Gamma	1 microgramo
ml	Mililitro		
mmol	milimol		
seg	segundo		
TA	Temperatura ambiente		
U.I.	Unidad internacional		
TSVP	Taquicardia supra ventricular paroxística		
cc	Centímetros cúbicos		

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 16 de 153	

8.- Desarrollo.

A continuación, se presentan Fichas de cada fármaco ordenadas alfabéticamente.

1.- ACICLOVIR

Antiviral

Presentaciones	FAL: 250 mg FA: 250 mg/10 ml	
Indicaciones	Tratamiento de infecciones causadas por herpes simplex, herpes zoster, varicela zoster.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura Ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	Según forma farmacéutica	Estabilidad T°A: No R: No
Dilución	7mg/ml. No exceder los 10 mg/ml, porque incrementa el riesgo de flebitis.	Estabilidad T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	En infusión intermitente > 60 minutos para prevenir el daño renal. Si desea uso de bomba de infusión usar ML/HR	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	La administración rápida puede producir falla renal y problemas a nivel del SNC como agitación, confusión, alucinaciones. Para reducir el riesgo de nefrotoxicidad, se sugiere asegurar una correcta hidratación del paciente, puede ser necesario utilizar bolos de SF concomitantes a la infusión. En pacientes con alteración de la función renal se usará con precaución y se reducirá la dosis diaria. La hemodiálisis ocasiona una reducción del 60% en las concentraciones plasmáticas. Puede causar dolor y flebitis en el sitio de inyección, se recomienda rotar el sitio de infusión. Evitar la extravasación, porque puede provocar necrosis. La refrigeración de las soluciones reconstituidas puede producir precipitado.	
Incompatibilidades	Acido tranexámico, cefepime, dobutamina, dopamina, foscarnet, gemcitabina, idarubicina, levofloxacino, meropenem, morfina, ondansetron, petidina, piperacilina/tazobactam, tacrolimus. Soluciones coloidales (soluciones que contienen proteínas), incompatibilidad solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 17 de 153	

2.-ÁCIDO TRANEXAMICO

Antifibrinolítico - Hemostático

Presentaciones AM: 1g/10 ml

Indicaciones	Hemorragias, púrpura, anemia aplásica, hemofilia, hemoptisis, epistaxis	
Contraindicaciones	Pacientes con hipersensibilidad al fármaco, pacientes con hipercoagulabilidad	
Almacenamiento	Temperatura ambiente. Protegido de luz.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	10 mg/ ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: SI EV infusión intermitente: SI EV infusión continua: SI	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar no sobrepasando los 100 mg/minuto. EV infusión intermitente: Administrar en 15 - 30 minutos. EV infusión continua: ML/HR	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Debe administrarse con extrema precaución en pacientes con trombosis. Pueden ocurrir náuseas, malestar torácico, palpitaciones, bradicardia, hipotensión cuando la inyección se hace en forma rápida. Se antagoniza su efecto con la warfarina. Se ajusta según función renal. Ampollas E.V. pueden ser administradas por vía oral.	
Incompatibilidades	Aciclovir, penicilina G, hemoderivados, heparina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 18 de 153	

3.- ÁCIDO VALPROICO

Antiepiléptico

Presentaciones FA: 500 mg/5 ml

Indicaciones	Prevención de episodios convulsivos, como el status convulsivo. Indicado como alternativa en los pacientes que no toleran el ácido valproico oral o son incapaces de recibirlo.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco, disfunción hepática, desórdenes del ciclo de la urea.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5% - SRL	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	10 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No	
Velocidad de la administración	EV directa: lenta 5 a 10 minutos. EV infusión intermitente: 60 minutos. La velocidad máxima recomendada es de 20 mg/minuto. EV infusión continua: Administrar a una velocidad de 1 – 4 mg/kg/hora, o bien a la indicación en ML/HR	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Evaluar signos y síntomas de hepatotoxicidad, pancreatitis, sedación y trombocitopenia si el tratamiento se extiende. El uso de terapias intravenosas por más de 14 días no ha sido estudiado y se recomienda pasar a la forma oral tan pronto sea posible. La monitorización mediante niveles es una herramienta muy útil para evaluar la seguridad y efectividad. En caso de monitorizarse niveles plasmáticos es muy importante ser rigurosos con los tiempos y ritmos de administración del fármaco, así como con el registro de los horarios de extracción de muestras. Las dosis intravenosas son equivalentes a las orales.	
Incompatibilidades	Por ser una nueva formulación no hay muchos estudios. Se recomienda no administrar en forma conjunta con otros medicamentos, terapia biológica o nutrición parenteral.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 19 de 153	

4.- ADENOSINA

Antiarrítmico

Presentaciones AM: 6 mg/2ml

Indicaciones	Reversión de taquicardia supra ventricular paroxística (TSVP)	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a adenosina. Enfermedad de nodo, bloqueo AV de segundo y tercer grado.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente, proteger de la luz, no refrigerar.	
Sueros compatibles	SF - SG5% - SRL	
Reconstitución	No requiere. Tiene estabilidad de 7 días una vez abierto el vial, a temperatura ambiente y protegido de la luz.	Estabilidad: T°A: 7 días R: No
Dilución	No requiere	
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Rápida 1 - 2 segundos.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Administrar en acceso E.V. cercano a corazón, preferentemente por CVC, con conexión de llave de tres pasos y con jeringa de suero fisiológico cargada, para facilitar administración rápida. Precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva. La inyección rápida por vía E.V. puede producir sensación de sofoco, náuseas, vómitos, dolor torácico, mareos, visión borrosa, cefaleas, sabor metálico, hiperventilación, rubicundez facial, bradicardia y asistolia transitoria (es frecuente, pero por lo general dura menos de 5 segundos y en realidad constituye el objetivo terapéutico). Se debe tener monitorización electrocardiográfica durante la administración, para visualizar la asistolia transitoria. No refrigerar porque puede precipitar.	
Incompatibilidades	No mezclar, ni administrar con otros fármacos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 20 de 153	

5.- ADRENALINA (EPINEFRINA)

Agonista alfa y beta - Adrenérgico

Presentaciones AM: 1 ml/mg

Indicaciones	Medicamento de primera línea en paro cardíaco, broncoespasmo, asma bronquial, shock anafiláctico, hipotensión por shock, bloqueo A - V transitorio. Como coadyuvante de la anestesia local.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco, arritmias cardíacas, glaucoma de angulo estrecho.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	EV directa: Se utilizará la dilución estándar 1 mg/10 ml de SF: 0,1 mg/ml. EV infusión continua: La dilución es 1:25. Cada cc de dilución tiene 40 mcg de adrenalina Habitual: 4 mg en 100 ml 8 mg en 200 ml 10 mg en 250 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: endotraqueal, intraósea	
Velocidad de la administración	EV directa: administrar lentamente EV infusión continua: La indicación se expresará en: mcg/kg/min Rango habitual: 0.01 a 1 mcg/kg/min	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	La administración rápida puede provocar hemorragias cerebrovasculares y arritmias cardíacas. Controlar la infusión, la extravasación produce necrosis. Es sensible a la luz, la oxidación provoca un cambio de color rosado a café, descartar la solución.	
Incompatibilidades	Aminofilina, ampicilina, bicarbonato de sodio. Las soluciones alcalinas inactivan a las catecolaminas.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 21 de 153	

6.- ALBUMINA 20 %

Sustituto del plasma- Expansor de volumen plasmático

Presentaciones FA: 10g/50 ml

Indicaciones	Hipoalbuminemia en cirrosis hepática, síndrome nefrótico, edema cerebral, hiperbilirrubinemia neonatal. Terapéutica sustitutiva del volumen circulatorio. Shock, traumatismo, quemaduras. Se ocupa como expansor tras plasmaféresis.	
Contraindicaciones	Historia de reacción alérgica a los preparados de albúmina.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF, SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	Puede ser diluido con SF o SG5%, no usar agua esteril porque esta asociado a hemolisis	Estabilidad: T°A: 4 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar 1 - 2 ml/minuto (30-60 minutos). La velocidad de administración debe ajustarse a las necesidades del paciente. Si desea uso de bomba de infusión usar ML/HR	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Una vez abierta utilizar en las próximas 4 horas, por riesgo de contaminación. Pueden presentarse reacciones como urticaria, enrojecimiento, fiebre, náuseas, hipotensión transitoria, fiebre y escalofríos. Estas reacciones son poco frecuentes y remiten en forma rápida al interrumpir la infusión. En casos aislados aparecen reacciones anafilácticas que pueden llegar a producir shock. Bajada de flebóclisis de albúmina 20% dura 24 horas. Evitar la administración rápida por riesgo de sobrecarga. La infusión se debe interrumpir inmediatamente si se presentan manifestaciones de sobrecarga circulatoria (cefaleas, disnea, ingurgitación yugular), excepto en pacientes hipovolémicos.	
Incompatibilidades	Aciclovir, midazolam, vancomicina, verapamilo En general no se recomienda pasar la albúmina junto con otros medicamentos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 22 de 153	

7.- AMIKACINA

Antibiotico. Aminoglicósido.

Presentaciones AM: 100 mg/2ml
AM: 500 mg/2ml

Indicaciones	Tratamiento de enfermedades infecciosas por microorganismos susceptibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco, sensibilidad cruzada con otros aminoglicósidos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	0,25 - 5 mg/ml Nunca exceder los 10 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R:No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si La dosis tal cual viene en la ampolla debe ser retirada y dada sin diluir en un músculo grande. Otras vías: Intratecal	
Velocidad de administración	30 – 60 minutos Si desea uso de bomba de infusión usar ML/HR	
Dializable	Si	
Observaciones RAM	- Medicamento nefrotóxico, ototóxico, neurotoxicidad. Es importante respetar los tiempos de administración debido al alto riesgo de reacciones adversas cuando la infusión es muy rápida. Monitorizar función renal, teniendo especial precaución con la reducción de la diuresis. Al administrar en conjunto una penicilina o una cefalosporina se debe lavar con suero fisiológico, ya que se pueden inactivar si éstas tienen contacto entre ellas. En caso de monitorizarse niveles plasmáticos es muy importante ser rigurosos con los tiempos y ritmos de administración del antibiótico, así como con el registro de los horarios de extracción de muestras.	
Incompatibilidades	Alopurinol, aminofilina, anfotericina B, betalactámicos (ampicilina, cefazolina), cloruro de potasio, dexametasona, fenitoína, heparina, hidroclorotiazida, propofol, soluciones a base de almidón. Incompatibilidad solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 23 de 153	

8.- AMINOÁCIDOS 10%

Aminoácidos esenciales y No esenciales - Complemento de Nutrición Parenteral

Presentaciones FA: 500 ml

Indicaciones	Carencia proteica por insuficiente ingestión de proteínas, por deficiente en la absorción o por pérdidas elevadas.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a algún aminoácido presente en la solución, anomalías congénitas del metabolismo de los aminoácidos, alteraciones graves de la circulación con riesgo vital (shock), hipoxia, acidosis metabólicas, enfermedad hepática avanzada, insuficiencia renal grave sin posibilidad de hemofiltración o hemodiálisis. Niños menores de 2 años de edad.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	No	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	No requiere	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: Si desea uso de bomba de infusión usar a 20 ML/HR Velocidad máxima: 0,1 g aminoácidos/kg/hr	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se deben monitorizar regularmente los electrolitos séricos, glucosa sanguínea, balance de fluidos, equilibrio ácido-base y la función renal (BUN, creatinina) y de función hepática. Administrar por vía central y/o periférica exclusiva (según evaluación enfermería). Cada frascos aporta sobre los 800 miliosmoles/lit. Bajada fleboclisis dura 24 horas	
Incompatibilidades	No conocidas	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 24 de 153	

9.- AMINOFILINA

Broncodilatador - Antiasmático.

Presentaciones AM: 250mg/10 ml

Indicaciones	Alivio sintomático o prevención del asma bronquial. Prevención del asma inducida por el ejercicio. Enfisema pulmonar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Apnea neonatal. Cuadro respiratorio de Cheyne - Stokes.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco	
Almacenamiento	Protegida de la luz	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	Dosis de carga: Diluir a 1 mg/ml. Máxima concentración 25 mg/ml. A concentraciones mayores aumenta la frecuencia de efectos adversos.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 48 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: Vo	
Velocidad de la administración	E.V. infusión intermitente: 30-60 minutos E.V. infusión continua: No exceder de 0,36 mg/kg/minuto. Reducir velocidad en situaciones especiales	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Al inicio de la terapia se puede observar: taquicardia, arritmias ventriculares o crisis convulsivas. Puede haber vómitos y pirosis, hipotensión, cefaleas, palpitaciones, escalofríos, fiebre, taquipnea, anorexia, nerviosismo o inquietud. A dosis bajas se puede observar un efecto diurético. Debe evaluarse la relación riesgo - beneficio en presencia de arritmias preexistentes, insuficiencia cardíaca congestiva, diarrea, gastritis activa, úlcera péptica activa, hipertrofia prostática, lesión miocárdica aguda, hipoxemia grave, enfermedad hepática e hipertiroidismo.	
Incompatibilidades	Adrenalina, amiodarona, ceftriaxona, cefotaxima, ciprofloxacino, diazepam, dobutamina, epinefrina, insulina, metilprednisolona, midazolam, morfina, ondansetron, penicilina G.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 25 de 153	

10.- AMIODORONA

Antiarrítmico

Presentaciones AM: 150mg/3ml

Indicaciones	Arritmias ventriculares (profilaxis y tratamiento), supra ventriculares, refractarias al tratamiento convencional, en especial cuando se asocian con el síndrome de Wolff - Parkinson - White. Paro cardiorrespiratorio (FV/TV sin pulso).	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a amiodarona o al yodo. Bloqueo A-V preexistente, bradicardia por disfunción severa del nódulo sinusal, salvo que esté controlada por un marcapaso, shock cardiogénico, embarazo.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SG 5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	1-6 mg/ml. Se recomienda utilizar el medicamento por vía central a concentraciones sobre 2 mg/ml (hasta 6 mg/ml) y en infusiones mayores a 60 minutos. EV directa: 150 -300 mg en 10-20 ml (solo en urgencias) EV infusión intermitente: 150 – 600 mg en 250 ml EV infusión continua: 600/ 250 ml 900/ 250 ml 1200/ 500 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: Vo	
Velocidad de la administración	EV directa: 150 -300 mg en 1-2 minutos EV infusión intermitente: 150 – 600 mg en 20 minutos a 2 horas EV infusión continua: 600 -1200 mg en 24 horas Velocidad de administración en MG/HR	
Dializable	No	
Observaciones RAM	– Se puede observar cefalea, temblores, neuropatía periférica, fatiga, ataxia, alteraciones del sueño, toxicidad pulmonar, hipotensión, bradicardia, náuseas, vómitos, fotosensibilidad, coloración azul grisácea de la piel, hipertiroidismo, alteraciones de la coagulación. Amiodarona paradójicamente es un fármaco pro arrítmico. Se debe tener precaución al usar concomitante con medicamentos que prolonguen el intervalo QT (cotrimoxazol, voriconazol, risperidona, etc.), en pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas (hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia) y en pacientes con disfunción hepática. No requiere protección de la luz cuando está diluida. La estabilidad es menor en envases de PVC. La mezcla con otros fármacos y sueros produce precipitación. Usar vía exclusiva.	
Incompatibilidades	Ampicilina, aminofilina, bicarbonato de sodio, cefazolina, ceftazidima, furosemida, imipenem - cilastatina, heparina, piperacilina-tazobactam, sales de foscato, suero ringer lactato, suero fisiológico, sulfato de magnesio.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 26 de 153	

11.-AMPICILINA

Antibiótico. Derivado de la Penicilina

Presentaciones FAL: 500 mg

Indicaciones	Infecciones bacterianas por organismos susceptibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco o a penicilinas	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	5-10 ml (si no se diluye una hora post reconstitución se debe desechar el vial, es más estable la solución diluida)	Estabilidad: T°A: 1 hr R: No
Dilución	30 mg/ml en infusión intermitente (no exceder esta concentración). 100 mg/ml en bolo.	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: 3-5 minutos (125-500 mg) y 10-15 minutos (1-2 g) EV infusión intermitente: 30 – 60 minutos EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR	
Dializable	Si	
Observaciones RAM	- Puede producir disnea, rash, urticaria, anafilaxis, diarrea, náuseas, vómitos, enterocolitis pseudomembranosa, anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, nefritis intersticial, sobreinfección. La administración E.V. muy rápida puede producir convulsiones. Observar posibles signos de anafilaxia durante los primeros minutos tras la administración. En pacientes con infección por CMV, virus Epstein - Barr o con leucemia linfoblástica aguda la posibilidad de rash por ampicilina es más alta que en la población normal.	
Incompatibilidades	Atracurio, clindamicina (se inactivan), anfotericina B, amikacina, clorpromazina, dopamina, epinefrina, fluconazol, gentamicina, gluconato de calcio, lorazepam, metoclopramida, midazolam, ondansetron, vancomicina,. Incompatibilidad solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 27 de 153	

12.- AMPICILINA – SULBACTAM

Antibacteriano. Asociación de derivado de penicilina con inhibidor de betalactamasas

Presentaciones FAL: Ampicilina 1000 mg/sulbactam 500 mg

Indicaciones	Tratamiento de infecciones causadas por organismos susceptibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes o a las penicilinas	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG 5%	
Reconstitución	Se reconstituye en 5 - 10 ml de suero. La concentración de ampicilina no debe exceder de 100 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 1 hr R: No
Dilución	La concentración a administrar debe ser de 2 - 30 mg/ml de ampicilina. Se calcula por Ampicilina.	Estabilidad: T°A: 8 hrs R: 48 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de administración	EV directa: Administrar en 10-15 minutos. EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 15-30 minutos	
Dializable	Si	
Observaciones RAM	- Puede producir disnea, rash, urticaria, náusea, vómito, diarrea, colitis pseudomembranosa, disuria, hematuria, tromboflebitis, vasculitis, dolor en el sitio de inyección, Sd. de Stevens - Johnson. Usar con precaución en pacientes con antecedentes de alergia general (asma, eccema, urticaria, fiebre del heno), enfermedad gastrointestinal (colitis ulcerosa, enteritis regional o colitis asociada con antibióticos). La administración muy rápida puede provocar convulsiones. Clearance de creatinina menor a 50 ml/minuto se debe ajustar la dosis. En pacientes con infección por CMV, virus Epstein-Barr o con leucemia linfoblástica aguda la posibilidad de rash por ampicilina es más alta que en la población normal.	
Incompatibilidades	Clindamicina (se inactiva). Anfotericina-B, amikacina, ciprofloxacino, clorpromazina, dopamina, epinefrina, fluconazol, gentamicina, idarubicina, metoclopramida, midazolam, ondasetron.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 28 de 153	

13.- ANFOTERICINA B DEOXCILATO

Antifúngico

Presentaciones FAL: 50 mg

Indicaciones	Tratamiento de infecciones sistémicas y del SNC causadas por hongos susceptibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco y cualquiera de sus componentes.	
Almacenamiento	Refrigerado, protegido de la luz.	
Sueros compatibles	SG5%	
Reconstitución	5 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: 7 días
Dilución	Vía periférica de 0,1 mg/ml Vía central 0,25 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	Dependiendo de la dosis y la tolerancia del paciente el tiempo de infusión debe ser de 4 - 6 hrs. A mayor tiempo de infusión menor riesgo de nefrotoxicidad. Velocidad de administración en ML/HR.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Pacientes que experimenten calofríos, fiebre, hipotensión, náuseas u otras reacciones no anafilácticas relacionadas a la infusión, se debe premedicar 30-60 minutos antes de la infusión con analgésicos no esteroideos o hidrocortisona 50-100 mg. La extravasación puede provocar irritación. Puede producir alteraciones hepáticas. La disfunción renal es frecuente, mantener una buena hidratación y balance hídrico neutro a negativo. Se recomienda prehidratar con SF. Pacientes que desarrollen disfunción renal se debe ajustar la dosis. Puede producir hipokalemia e hipomagnesemia. No confundir este preparado con las formulaciones lipídicas en las cuales se ocupan otras dosis y diluciones.	
Incompatibilidades	Suero fisiológico solidifica la solución (no se debe utilizar). No se recomienda su administración en vía con otros medicamentos, por alto riesgo de incompatibilidad.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 29 de 153	

14.- ANFOTERICINA B LIPOSOMAL

Antifúngico

Presentaciones FAL: 50 mg

Indicaciones	Tratamiento de infecciones sistémicas y del SNC causadas por hongos susceptibles.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Refrigerado, proteger de la luz.	
Sueros compatibles	SG 5%	
Reconstitución	Reconstituir con 12 ml de agua destilada a una concentración de 4 mg/ml, agitar vigorosamente durante 30 segundos hasta obtener una suspensión amarilla traslúcida.	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Dilución	SG 5% hasta una concentración final de 0,5 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 6 hrs R: No hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	Dependiendo de la dosis y la tolerancia del paciente la velocidad de infusión debe ser de 2,5 mg/kg /hr (1 - 2 horas); o también la velocidad de administración puede ser en ML/HR	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	La nefrotoxicidad y reacciones asociadas a la infusión son menores en comparación con la anfotericina B deoxicolato. Sin embargo pueden presentarse alteraciones hidroelectrolíticas, cardiovasculares, neurológicas, hematológicas y hepáticas.	
Incompatibilidades	Incompatible con SF y otras soluciones salinas.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 30 de 153	

15.- ANIDULAFUNGINA

Antifúngico. Equinocandina

Presentaciones FAL: 100 mg

Indicaciones	Tratamientos en infecciones fúngicas por candidas.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco	
Almacenamiento	Refrigerado	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	Reconstituir con 30 ml para 100 mg y 60 ml para 200 mg.	Estabilidad: T°A: No R: 1 hora
Dilución	Diluir 100 mg en 100 ml de suero Diluir 200 mg en 200 ml de suero	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	Administrar lentamente en 90 a 180 min. no sobrepasando una velocidad de infusión de 1,1 mg/min.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Hipokalemia, diarrea, incremento de las transaminas. La velocidad de infusión no debe exceder la indicación, ya que puede producir hipotensión.	
Incompatibilidades	Anfotericina B, bicarbonato de sodio, ertapenem.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 31 de 153	

16.- ATRACURIO BESILATO

Relajante Muscular

Presentaciones AM: 25 mg/2,5ml

Indicaciones	Como adyuvante para la anestesia general para facilitar la intubación traqueal, como relajante durante la cirugía o la ventilación controlada, para facilitar la ventilación mecánica de pacientes en UCI.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a atracurio, cisatracurio o ác. bencenosulfónico.	
Almacenamiento	Refrigerado	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	0,5 a 2,5 mg/mL Habitual: 600 MG/250 ML	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar en bolo entre 20 y 90 segundos. EV infusión continua: La indicación será en mg/Kg/hora. El rango será de 0,3 a 0,6 mg/Kg/hora.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones – RAM	Administrar sólo con anestesia general adecuada, control por un técnico experimentado y en instalaciones adecuadas para intubación endotraqueal y ventilación artificial. Se han observado reacciones comunes tales como: taquicardia, hipotensión transitoria, broncoespasmo, respiración sibilante, enrojecimiento cutáneo, urticaria. No administrar a través del mismo sistema de infusión que una transfusión sanguínea porque puede causar hemólisis. Reacciones de hipersensibilidad, pacientes con historial de alergia o asma (posibilidad de broncoespasmo), se recomienda monitorización. Bloqueo vagal.	
Incompatibilidades	Cefazolina, diazepam, heparina, nitroprusiato, propofol, ringer lactato, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 32 de 153	

17.- ATROPINA SULFATO 1 %

Anticolinérgico - Antiespasmódico.

Presentaciones AM: 1 mg/1ml

Indicaciones	Bradicardia sintomática secundaria a estimulación vagal. Sobredosis por órganos-fosforados. Antiespasmódico por su acción sobre el músculo liso. Utilizado también como medicación preanestesia y para contrarrestar los efectos muscarínicos de las anticolinesterasas como la neostigmina y otros para-simpaticomiméticos.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la atropina. Glaucoma de ángulo cerrado, taquiarritmias, tirotoxicosis. Contraindicado en pacientes con hipertrofia prostática, en los cuales puede causar retención urinaria y en aquellos con íleo paralítico o estenosis pilórica.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF, SG 5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	Dilución estándar 1 mg/10 ml de suero fisiológico (0,1 mg/ml)	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: Endotraqueal.	
Velocidad de administración	Bolo rápido, la administración lenta puede provocar bradicardia paradójica	
Dializable	Sin datos	
Observaciones RAM	- Arritmia, hipotensión, taquicardia, ataxia, delirium, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, íleo paralítico, distensión abdominal, retención urinaria, midriasis, visión borrosa, urticaria, disnea, laringoespasma. Para evitar la bradicardia paradójica no se debe usar dosis inferiores a la mínima (0,1 mg). Mantener monitorización electrocardiográfica y supervisión de la frecuencia cardíaca.	
Incompatibilidades	Norepinefrina, tiopental	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 33 de 153	

18.- AZITROMICINA

Antibiótico Macrólido

Presentaciones FAL: 500 mg

Indicaciones	Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad causada por microorganismos sensibles, en pacientes adultos inmunocompetentes que cumplan criterios de hospitalización.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a azitromicina, eritromicina o a cualquier otro antibiótico macrólido o ketólido.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	100 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Dilución	Concentración de 1 mg/ml en 500 ml Concentración de 2 mg/ml en 250 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 7 días
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Concentraciones de 1mg/ml pasar en 3 horas Concentraciones de 2 mg/ml en 1 hora	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Diarrea, náuseas, prurito, rash, inflamación y dolor en el sitio de administración, prolongación QT.	
Incompatibilidades	No se deberá añadir a azitromicina ninguna otra sustancia intravenosa, aditivos o medicamento, ni ser infundidas al mismo tiempo por la misma vía venosa.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 34 de 153	

19.- BASILIXIMAB

Inmunosupresor. Anticuerpo Monoclonal

Presentaciones FAL: 20 mg

Indicaciones	Prevención del rechazo de órganos en trasplante renal.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a basiliximab, embarazo, lactancia	
Almacenamiento	Refrigerado	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	5 ml de suero	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Dilución	0,2 mg/ml	Estabilidad: T°A: 4 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos Infusión intermitente: Administrar 20-30 minutos	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Reacciones de hipersensibilidad severas y agudas (en menos de 24 horas), tanto en la exposición inicial, como en la re-exposición. Estas incluyen urticaria, prurito, hipotensión, taquicardia, disnea, broncoespasmo, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. Si aparece una reacción de hipersensibilidad severa, se deberá interrumpir el tratamiento permanentemente y no administrar ninguna dosis posteriormente.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 35 de 153	

20.- BETAMETASONA

Corticoesteroide

Presentaciones AM: 4 mg/1ml

Indicaciones	Insuficiencia adrenocortical, inflamación y desordenes alérgicos, asma.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco, a otros corticoides, infecciones fungicas sistemicas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	1 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar en 1 minuto. EV intermitente: Administrar en 20 - 60 minutos	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Hipersensibilidad (anafilaxia, broncoespasmo, shock), necrosis aséptica, osteoporosis, intolerancia a la glucosa, retención de sodio, retención de fluidos, hipokalemia, supresión adrenal. Dolor u hormigueo cerca del lugar de la inyección, hipotensión, hipertensión, urticaria, sensación de falta de aire y sofocos en la cara.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 36 de 153	

21.- BICARBONATO DE SODIO 8,4%

Electrolito - Agente alcalinizante.

Presentaciones AMP de 10 ml: Contiene 0,84 g de bicarbonato de sodio.

Indicaciones	Tratamiento de la acidosis metabólica, como agente alcalizante de la orina, hiperkalemia, manejo de sobredosis de medicamentos como antidepresivos tricíclicos y aspirina.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco, alcalosis metabólica, hipernatremia, edema pulmonar severo, hipocalcemia.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG 5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	0,5 – 1 mEq/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si (solo por CVC no diluido) EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: Intraósea	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR y a no mas de 1 mEq/kg/hr En bolo no exceder 1 - 2 mEq/kg/min o 10 mEq/min	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Hipernatremia, edema, hiperosmolaridad, hipokalemia, hipocalcemia, alcalosis metabólica. Inactiva a las catecolaminas, nunca administrarlas juntas. No mezclar con gluconato de calcio, se forma un precipitado en forma de cristales de carbonato de calcio insoluble (de color blanco), que obstruyen catéteres. Se prefiere la vía central para la administración, pero se puede infundir en una vena de grueso calibre diluida al tercio, con la finalidad de disminuir los riesgos de necrosis por extravasación, el bicarbonato es muy hipertónico. No administrar endotraqueal.	
Incompatibilidades	Amiodarona, atropina, dobutamina, dopamina, epinefrina, gluconato de calcio, labetalol, lidocaína, midazolam, norepinefrina, ondansetron, rocuroonio, verapamilo.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 37 de 153	

22.- BROMURO DE ROCURONIO

Bloqueador Neuromuscular No despolarizante

Presentaciones	FA: 50 mg/5 ml	
Indicaciones	Coadyuvante de la anestesia, induce relajación del músculo esquelético y facilitar la ventilación mecánica y la intubación traqueal.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a los bloqueantes neuromusculares.	
Almacenamiento	Refrigerar 2 - 8 °C	
Sueros compatibles	SF – SG 5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	0,5 - 2 mg/ml Habitual: 200 MG/100 ML 400 MG/ 200 ML 500 MG/ 250 ML	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs Ambos después de diluidos
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Bolo de 3 - 5 min Infusión continua: Velocidad de administración habitual en mg/kg/hr	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar hipotensión, excepcionalmente broncoespasmo, depresión respiratoria, hipersecreción bronquial, edema, taquicardia, prurito, mareos. Localmente, en el lugar de la inyección puede aparecer dolor. Puede presentarse parálisis prolongada tras infusiones mayores a las 6 horas, por acumulación de metabolitos activos. Calcular la dosis en relación al peso corporal magro en pacientes obesos.	
Incompatibilidades	No mezclar con soluciones alcalinas. Anfotericina-B, amoxicilina, cefazolina, cloxacilina, cotrimoxazol, dexametasona, diazepam, furosemida, insulina, ketorolaco, lorazepam, metilprednisolona, tiopental y vancomicina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 38 de 153	

23.- BUPIVACAINA

Anestésico

Presentaciones	AMP: 0.5% 50 mg/10ml AMP: 0.75% 15 mg/2ml	
Indicaciones	Anestesia local para bloqueo de nervios periféricos, infiltración, bloqueo simpático, caudal o epidural, bloqueo retrobulbar.	
Contraindicaciones	Contraindicada para el bloqueo para cervical obstétrico y para anestesia regional IV (bloqueo de Bier). Hipersensibilidad a la bupivacaína, anestésicos locales tipo amida.	
Almacenamiento	No refrigerar y protegida de la luz.	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	La dosis dependerá del objetivo terapéutico, siendo responsabilidad del anestesista su indicación. Diluir en 250 ml SF	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: Epidural, infiltración local.	
Velocidad de la administración	Según indicación médica y objetivo terapéutico.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Mantener monitorización según protocolo de manejo del dolor agudo post operatorio. Puede observarse inquietud, excitabilidad, nerviosismo, parestesias, vértigo, visión borrosa, náuseas, vómitos, espasmos musculares, temblores y convulsiones. El entumecimiento de la lengua y la región peri-oral y la pérdida del conocimiento, seguidos de sedación pueden ser signos incipientes de toxicidad sistémica. La excitabilidad, puede ser pasajera y seguida de depresión con adormecimiento, insuficiencia respiratoria y coma. Puede presentarse insuficiencia miocárdica y vasodilatación periférica, que produce hipotensión y bradicardia, a veces produce arritmias y paro cardíaco. La anestesia epidural, a menudo se acompañan de hipotensión. La posición incorrecta de la paciente, puede ser un factor desencadenante en las mujeres durante el parto.	
Incompatibilidad	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 39 de 153	

24.- ESCOPOLAMINA

Antiespasmódico - Anticolinérgico

Presentaciones AM: 20 mg/ml

Indicaciones	Espasmos agudos del tracto gastrointestinal, biliar y genitourinario, incluyendo cólico biliar y renal. Coadyuvante en aquellos procesos de diagnóstico y terapéutica en los que el espasmo puede suponer un problema, como la endoscopia gastro-duodenal y la radiología.	
Contraindicaciones	Pacientes con glaucoma de ángulo abierto no tratado, hipertrofia prostática, ileo paralítico u obstructivo, megacolon, miastenia gravis. Hipersensibilidad al medicamento.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	1 mg/1 ml	Estabilidad: T°A: No R: No
	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: SC	
Velocidad de la administración	EV directa: Inyectar lentamente, sobre 1 a 2 min. Infusión continua: 5 a 10 mg/hr	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Sequedad bucal, visión borrosa, taquicardia. Como el resto de anticolinérgicos, puede inhibir la secreción de leche. En caso de sobredosificación pueden presentarse síntomas anticolinérgicos, tales como: retención urinaria, sequedad de boca, rubefacción cutánea, taquicardia, inhibición de la motilidad gastrointestinal y trastornos pasajeros de la visión. El tratamiento concomitante con antagonistas dopaminérgicos tales como la metoclopramida, puede dar como resultado la disminución del efecto de ambos fármacos sobre el tracto gastrointestinal.	
Incompatibilidades	No debe mezclarse con otros medicamentos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 40 de 153	

25.- CASPOFUNGINA

Antifúngico - Equinocandina

Presentaciones FAL: 50 y 70 mg.

Indicaciones	Tratamiento de candidiasis incluyendo candidemia y otras infecciones por candida. Aspergilosis invasiva en pacientes que son refractarios o intolerantes a otros tratamientos.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Refrigerado	
Sueros compatibles	SF- SRL	
Reconstitución	FAL de 50 mg: 10,8 ml de API o SF a una concentración final de 5 mg/ml FAL de 70 mg: 10,8 ml de API o SF a una concentración final de 7 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hr R: No
Dilución	Concentración máxima para administración: 0,5 mg /ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: mínimo en 1 hora.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar edema palpebral, fiebre, dolor de cabeza, insomnio, rash, prurito, eritema, vómito, diarrea, anemia, flebitis, tromboflebitis, mialgia, proteinuria, hematuria, broncoespasmo, anafilaxia, diaforesis.	
Incompatibilidades	Soluciones con glucosa. No mezclar con otros medicamentos por la misma vía, debido a la escasa cantidad de datos disponibles sobre compatibilidades.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 41 de 153	

26.- CALCIO GLUCONATO 10 %

Electrolito

Presentaciones Cada ampolla de 10 ml aporta 9.776 mg de gluconato de calcio
 Contiene 0,47 mEq de gluconato y 0,47 mEq de Calcio

Indicaciones	Tratamiento y prevención de la hipocalcemia, tratamiento del tetano, suplementación de calcio, alteraciones cardiacas por hipercalemia.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco, fibrilación ventricular, cálculo renal, hipercalcemia, hipofosfemia, sospecha de intoxicación digitalica.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG 5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	50 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si (sin diluir, por CVC) EV infusión intermitente: Si (sin diluir o diluido, por CVC) EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: VO	
Velocidad de la administración	Directa: Solo en paro cardiaco se puede dar en 10 - 20 seg. Infundir en un mínimo de 5 minutos no sobrepasando de 50 – 100 mg de gluconato de calcio/min. Infusión: Velocidad de administración en ML/HR. No exceder los 120 - 240 mg de gluconato de calcio/kg/h (0,6 - 1,2 mEq calcio elemental/kg/h).	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar vasodilatación, hipotensión, bradicardia, arritmias cardiacas, fibrilación ventricular, sincope, letargia, coma, eritema, disminuye niveles de magnesio, hiperkalemia, hipercalcemia, contracción muscular. Su extravasación provoca necrosis, administrar solo por CVC, nunca por I.M. o S.C. Su uso puede causar paro cardiaco, usar con precaución en pacientes con tratamiento con digitálicos, falla respiratoria, acidosis, falla renal.	
Incompatibilidades	Anfotericina B, ampicilina, bicarbonato de sódio, cefazolina, ceftriaxona, clindamicina, dobutamina, fluconazol, hidrocortisona, metilprednisolona, meropenem, metoclopramida, magnesio, sales de fosfatos, sales de sulfato.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 42 de 153	

27.- CEFAZOLINA

Antibacteriano. Cefalosporina de primera generación

Presentaciones FAL: 1000 mg (como sal sódica)

Indicaciones	Infecciones por microorganismos sensibles, del tracto respiratorio y genitourinario, de la piel y tejidos blandos. Infecciones osteoarticulares y otorrinolaringológicas.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a las cefalosporinas, penicilinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG 5%	
Reconstitución	5 -20 ml de suero	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 96 hrs
Dilución	100 mg/ml	Estabilidad: T°A: 8 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar lentamente entre 30 a 60 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar irritación, rash, urticaria, prurito, Sd. Stevens - Johnson, náuseas, vómitos, diarrea, colitis pseudomembranosa, leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia, neutropenia, tromboflebitis, dolor en el lugar de inyección, falla renal, anafilaxia. Las soluciones reconstituidas con concentraciones sobre 330 mg/ml, pueden precipitar.	
Incompatibilidades	Amikacina, amiodarona, anfotericina B, atracurio, bleomicina, gluconato de calcio, colistimetato, idarubicina, lidocaína, ranitidina, vancomicina. Incompatibilidad solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 43 de 153	

28.- CEFEPIME

Antibacteriano. Cefalosporina de cuarta generación.

Presentaciones FAL: 1000 mg (presentación disponible en el hospital).

Indicaciones	Tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos susceptibles como neumonía, infecciones del tracto urinario, piel y tejidos blandos, bacteremia, tratamiento empírico de neutropenia febril, meningitis bacteriana.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a las cefalosporinas o penicilinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz.	
Sueros compatibles	SF – SG 5%	
Reconstitución	Reconstituir con 10 ml de suero. La concentración reconstituida recomendada es de 100 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 6 hrs R: 24 hrs
Dilución	1 - 40 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 7 días
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos EV infusión intermitente: Administrar lento 30 - 60 min. EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Puede provocar dolor de cabeza, fiebre, rash maculopapular, prurito, urticaria, diarrea, náuseas, vomito, colitis pseudomembranosa, neutropenia finalizada la terapia, leucopenia y trombocitopenia transitoria, flebitis, anafilaxia, encefalopatía, anemia. Como ocurre con otras cefalosporinas, el color del polvo y la solución de cefepime puede oscurecerse al almacenarse, sin embargo, esto no afecta su potencia.	
Incompatibilidades	Aciclovir, anfotericina B, clorpromazina, ciprofloxacino, cisplatino, dacarbazina, daunorubicina, diazepam, dobutamina, dopamina, doxorubicina, droperidol, etoposido, filgrastim, ganciclovir, haloperidol, idarubicina, ifosfamida, magnesio sulfato, manitol, metoclopramida, mitomicina, mitoxantrona, morfina, ondansetron, vancomicina, vinblastina, vincristina. Incompatibilidad en mezcla: aminoflina, ampicilina, gentamicina, metronidazol.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 44 de 153	

29.- CEFOPERAZONA - SULBACTAM

Antibacteriano. Asociación de cefalosporina con inhibidor de betalactamasas.

Presentaciones FAL: cefoperazona 1000 mg (como sal sódica)/Sulbactam 500 mg (como sal sódica).

Indicaciones	Tratamiento de infecciones polimicrobianas severas en que se sospecha presencia de microorganismos aerobios y anaerobios.	
Contraindicaciones	Pacientes con hipersensibilidad a las cefalosporinas y penicilinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz (una vez reconstituido no necesario).	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	250 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 48 hrs
Dilución	10 - 50 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 7 días
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 15 – 60 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar diarrea, vómito, exantema maculopapular, urticaria, eosinofilia, fiebre medicamentosa, cefalea, dolor en el sitio de inyección, neutropenia reversible, elevación transitoria del BUN y creatinina. Observar por signos de anafilaxis durante los primeros minutos tras la administración. En administración intramuscular precaución con la dosis por sitio a administrar. Se puede ocupar lidocaína como disolvente (con precaución).	
Incompatibilidades	Anfotericina B, amikacina, filgrastim, fluconazol, gemcitabina, gentamicina, ondansetron.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 45 de 153	

30.- CEFOTAXIMA

Antibacteriano. Cefalosporina de tercera generación.

Presentaciones FAL: 1000 mg (como sal sódica).

Indicaciones	Tratamiento de las Infecciones por microorganismos sensibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a las cefalosporinas o pacientes que han presentado hipersensibilidad a penicilinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz (una vez reconstituido no necesario).	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	Reconstituir en 10 ml de suero compatible	Estabilidad: T°A: No R: 6 hrs
Dilución	20 - 60 mg/ml hasta un máximo de 100 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 7 días
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: So Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar lentamente sobre los 30 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Puede provocar dolor de cabeza, rash, prurito, diarrea, náuseas, vómitos, neutropenia transitoria, trombocitopenia, elevación transitoria del BUN y creatinina, flebitis, fiebre, anafilaxia. La administración en menos de un minuto puede provocar arritmias.	
Incompatibilidades	Alopurinol, aminofilina, aminoglicósidos, bicarbonato de sodio, filgrastim, fluconazol, gemcitabina, vancomicina. Incompatibilidad en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 46 de 153	

31.- CEFTAZIDIMA - AVIBACTAM

Antibiótico. Cefalosporina tercera generación más inhibidor de betalactamasa

Presentaciones FAL: 2500 mg (Cefatazidima 2000 mg + Avibactam 500 mg)

Indicaciones	Indicado en adultos para el tratamiento de las siguientes infecciones: infección Intraabdominal complicada, infección complicada del tracto urinario, incluyendo pielonefritis, neumonía adquirida en el hospital y neumonía asociada a ventilación mecánica. También esta indicado para el tratamiento de infecciones por microorganismos gram-negativos en pacientes adultos con opciones terapéuticas limitadas.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Hipersensibilidad a cualquier tipo de β -lactámico (p.ej. penicilinas, monobactámicos o carbapenémicos).	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5% - SRL	
Reconstitución	10 ml de suero. El vial reconstituido debe utilizarse inmediatamente. El tiempo transcurrido entre el inicio de la reconstitución y el final de la preparación de la dilución no debe exceder los 30 min. La solución reconstituida es una solución de color amarillo pálido y libre de partículas.	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	100 ml de suero	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Se administra mediante perfusión intravenosa durante 120 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Las reacciones adversas más frecuentes son náuseas y diarrea. Otras RAM son eosinofilia, trombocitosis, trombocitopenia, cefalea, mareo, elevación de transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT y LDH, erupción maculopapular, urticaria, prurito, trombosis y flebitis en el lugar de la perfusión.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 47 de 153	

32.- CEFTAZIDIMA

Antibacteriano. Cefalosporina de tercera generación

Presentaciones FAL: 1000 mg

Indicaciones	Tratamiento en infecciones causadas por microorganismos sensibles (infecciones del tracto respiratorio, tracto urinario, septicemia, infecciones de tejido óseo y articulaciones, ginecológicas, intraabdominales y del sistema nervioso central).	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a las cefalosporinas o a penicilinas	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	100 mg/ml	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: 3 días
Dilución	40 mg/ml	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: 3 días
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 15 – 30 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Puede provocar dolor de cabeza, rash, náuseas, vómitos, leucopenia transitoria, anemia hemolítica, flebitis, elevación transitoria de BUN, creatinina, hiperbilirrubinemia, mioclonia, anafilaxis. A medida que se disuelve el producto se libera dióxido de carbono y se desarrolla una presión positiva, debe asegurarse de que no quede gas (burbujas de CO ₂) en la jeringa antes de administrar.	
Incompatibilidades	Bicarbonato sodio, anfotericina B, aminofilina, aminoglicósidos, doxorubicina liposomal, fluconazol, idarubicina, midazolam, ranitidina. Incompatibilidad solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 48 de 153	

33.- CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM

Antibacteriano. Cefalosporina asociada a inhibidor de betalactamasa

Presentaciones FAL: 1,500 mg

Indicaciones	Tratamiento de infecciones intrabdominales y urinarias complicadas, incluyendo pielonefritis.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a las cefalosporinas o a penicilinas	
Almacenamiento	Entre 2-8°C y protegido de la luz.	
Sueros compatibles	API - SF – SG5%	
Reconstitución	10 ml de API - SF	Estabilidad: T°A: 1 hrs R: 24 hrs
Dilución	100 ml de SF – SG5%	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar en 60 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Anemia, trombosis, fibrilación auricular, dolor abdominal, constipación, diarrea, náuseas, vómitos.	
Incompatibilidades	No debe mezclarse con otros fármacos ni debe ser físicamente agregado a soluciones que contienen otros fármacos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 49 de 153	

34.- CEFTRIAXONA

Antibacteriano. Cefalosporina de tercera generación

Presentaciones FAL: 1000 mg

Indicaciones	Infecciones producidas por microorganismos sensibles en sepsis, meningitis, infecciones abdominales (peritonitis, infecciones gastrointestinales o de las vías biliares), infecciones óseas, articulares, de tejidos blandos o piel, infecciones urinarias y renales, infecciones respiratorias sobre todo neumonías, infecciones genitales incluida la gonococia.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a las cefalosporinas o a penicilinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	100 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Dilución	10 - 40 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar lentamente sobre 30 minutos.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Puede provocar rash, diarrea, náuseas, vómitos, colitis, coleditiasis, ictericia, trombocitopenia, leucopenia, anemia, prurito, dolor en lugar de administración, elevación del BUN, creatinina y bilirrubina, anafilaxia.	
Incompatibilidades	No administrar en la misma vía ni mezclar con soluciones que contengan calcio ni suero ringer lactato. Anfotericina B, aminofilina, azitromicina, clindamicina, filgrastim, fluconazol, gentamicina, labetalol, linezolid, metronidazol, vancomicina. Incompatibilidad solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 50 de 153	

34.- CEFUROXIMA

Antibacteriano.Cefalosporina de segunda generación

Presentaciones FAL: 750 mg

Indicaciones	Utilizado en el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles, como las infecciones óseas y articulares, bronquitis y otras enfermedades del aparato respiratorio inferior, gonorrea, meningitis, otitis media, peritonitis, faringitis, sinusitis, infecciones cutáneas y las infecciones del tracto urinario. Infecciones obstétricas y ginecológicas, enfermedades inflamatorias de la pelvis.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la cefuroxima y a cualquiera de los componentes de la formulación u otras cefalosporinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	100 mg/ml	Estabilidad: T°A: 5 hrs R: 48 hrs
Dilución	30 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No días
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 15 – 60 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Molestias digestivas como diarrea, náuseas y vómitos. Comparte las reacciones adversas de otras cefalosporinas.	
Incompatibilidades	Aminoglicosidos, bicarbonato de sodio, filgastrin, fluconazol, midazolam.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 51 de 153	

36.- CIPROFLOXACINO

Antibacteriano. Quinolona

Presentaciones	MTZ: 200 mg/ 100 ml	
Indicaciones	Infecciones producidas por microorganismos sensibles en sepsis, meningitis, infecciones abdominales (peritonitis, infecciones gastrointestinales o de las vías biliares), infecciones óseas, articulares, de tejidos blandos o la piel, heridas infectadas, infecciones en pacientes con disminución de los mecanismos de defensa, infecciones urinarias y renales, infecciones respiratorias (sobre todo neumonías e infecciones ORL), infecciones genitales incluida la gonococia y profilaxis peri operatoria de las infecciones.	
Contraindicaciones	En casos de hipersensibilidad al mismo, a otras quinolonas o cualquiera de los excipientes.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente (A no más de 25 °C).	
Sueros compatibles	SF – SG 5% - SRL	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	No requiere	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar sobre los 60 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Dolor de cabeza, disnea, confusión, rash, anemia, dispepsia, vértigo, convulsiones, artralgia, náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, incrementa niveles de creatinina, torsades de pointes, hipertensión, hipotensión, taquicardia, fotosensibilidad, diaforesis, anafilaxia, Sd. de Stevens - Johnson, prurito, puede aparecer un aumento en el valor de enzimas hepáticas. Puede provocar flebitis o tromboflebitis.	
Incompatibilidades	Aminoflina, ampicilina/sulbactam, cefepime, clindamicina, dexametasona, fenitoina, furosemida, heparina, hidrocortisona, metilprednisolona, propofol, sulfato de magnesio.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 52 de 153	

37.- CLINDAMICINA

Antibiótico. Lincosamida

Presentaciones AM: 300 mg /2 ml
AM: 600 mg/4 ml

Indicaciones	Tratamiento de infecciones óseas por estafilococos, infecciones genitourinarias, gastrointestinales y neumonías por anaerobios, septicemias por anaerobios, estafilococos y estreptococos, infecciones de piel y tejidos blandos por microorganismos susceptibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a las lincosamidas, colitis ulcerosa, colitis pseudomembranosa previa.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	6 - 12 mg/ml. Máxima concentración 18 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 7 días
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar 300 mg/10 min, 600 mg/20 min, 900 mg/30 min No sobrepasar los 30 mg/minuto o 1200 mg/hora.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Puede causar tromboflebitis, hipotensión, arritmia, urticaria, rash, prurito, náuseas, vómitos, diarrea, colitis pseudomembranosa, hipersensibilidad, anafilaxia, bloqueo neuromuscular, aumento reversible de las transaminasas hepáticas, trombocitopenia y granulocitopenia. La infusión rápida se asocia a hipotensión o paro cardiorrespiratorio.	
Incompatibilidades	Aminoflina, ampicilina, fenitoina, filgastrim, fluconazol, gluconato de calcio, idarrubicina, magnesio, tobramicina. Incompatibilidad solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 53 de 153	

38.- CLORFENAMINA MALEATO

Antihistamínico

Presentaciones AM: 10 mg/1 ml

Indicaciones	Prurito asociado con reacciones alérgicas. Shock anafiláctico.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG 5 %	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	1 - 2 mg/ml.	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: S.C.	
Velocidad de la administración	EV directa: Lentamente en 3 a 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar entre 10 y 30 minutos.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar somnolencia y disminución de la acción refleja, nerviosismo, palpitaciones, convulsiones, alteraciones gastrointestinales, diarrea, sequedad bucal, vómitos, náuseas, dermatitis, poliurea, foto sensibilidad, fatiga, diplopía.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 54 de 153	

39.- CLONIXINATO DE LISINA

Analgesico – Antipiretico - Antiinflamatorio No esteroideal

Presentaciones AM: 100 mg/ 2 ml

Indicaciones	Alivio de cefaleas, dolores musculares, articulaciones, neuríticas, odontalgias, otalgia, dismenorrea, dolores postraumáticos o post-quirúrgicos.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al clonixinato de lisina o cualquiera de sus componentes	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	5 mg/ ml	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Lentamente en 3 a 5 minutos. Infusión intermitente: no menos de 15 min. Infusión continua: 20 ml/hr	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Náuseas, vómitos, gastritis y somnolencia. No potencializa los efectos de anticoagulantes ni interfiere con el tiempo de coagulación	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 55 de 153	

40.- CLORPROMAZINA

Neuroléptico – Antipsicótico - Antiemético.

Presentaciones AM: 25 mg/2 ml

Indicaciones	Tratamiento de desórdenes psicóticos. Como ayudante en el manejo a corto plazo de excitación, agitación psicomotora, conducta violenta o peligrosamente impulsiva. Control de náusea y vómitos.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco y a cualquiera de sus componentes	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	1 mg/ml	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Lentamente en 3 minutos. EV infusión intermitente: No menos de 30 minutos.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Puede causar hipotensión ortostática, taquicardia, arritmia, ansiedad, inquietud, somnolencia, reacciones extra piramidales, discinesia, mareos, alteración para la regulación de la temperatura central, reacción distónica aguda, hiperpigmentación, prurito, rash, malestar gastrointestinal, constipación, ictericia, colestasia, leucopenia, agranulocitosis, trombocitopenia, anemia hemolítica, eosinofilia, visión borrosa, retención urinaria, fotosensibilidad, tromboflebitis, reacciones anafilácticas. La vía endovenosa es muy irritante y dolorosa, debe reservarse solo para casos muy necesarios. Monitorizar la presión arterial durante la infusión y después de ésta, la primera inyección produce generalmente hipotensión postural y las inyecciones subsecuentes también la pueden producir. El paciente se recupera espontáneamente a las 2 horas como máximo. Para minimizar los problemas de hipotensión mantener al paciente recostado mientras dure la infusión. Si la solución se torna de un ligero color amarillo la potencia no se altera. Pero si este amarillo se vuelve intenso, eliminar la solución.	
Incompatibilidades	No mezclar con soluciones alcalinas. Alopurinol, aminofilina, anfotericina B, ampicilina, cefepime, fenobarbital, etoposido fosfato, fudarabina, furosemida, heparina, linezolid, metotrexato, paclitaxel, penicilina G potásica, piperacilina/tazobactam, remifentanilo, tiopental. Solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 56 de 153	

41.- CLOXACILINA

Antibacteriano. Betalactámicos derivado de la penicilina.

Presentaciones FAL: 500 mg

Indicaciones	Infecciones causadas por microorganismos susceptibles.	
Contraindicaciones	Antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	100 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Dilución	10- 50 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 30 – 40 minutos. I.M. Administrar lentamente en 2 - 4 minutos.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Reacciones de hipersensibilidad, trombocitopenia, neutropenia, elevación de enzimas hepáticas, insuficiencia renal, flebitis, rash, diarrea, vómitos, náuseas, convulsiones, confusión, artralgia, mialgia, broncoespasmo, hipotensión. La administración E.V. muy rápida puede producir convulsiones.	
Incompatibilidades	Gentamicina, amikacina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 57 de 153	

42.- COLISTIMETATO SODICO

Antibacteriano

Presentaciones AM:1.000.000 UI/10 ml (80 mg)

Indicaciones	Tratamiento de algunas infecciones graves causadas por microorganismos gram – negativos.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	100.000 UI /ml (vía periférica) 200.000 UI/ ml (vía central)	Estabilidad: T°A: No R: 7 días
Dilución	10.000 UI/ ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si. Cuando el paciente tiene CVC puede tolerar dosis de hasta 2.000.000 UI en 10 ml. EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Mínimo en 5 - 10 minutos. EV infusión intermitente: Mínimo 30 min. Preferir la administración en el mayor tiempo posible para reducir el riesgo de efectos adversos. Si desea uso de BIC, velocidad de administración en ML/HR	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar disartria, vértigo, mareos, fiebre, ataxia, confusión mental, convulsiones, prurito, urticaria, rash, malestar gastrointestinal, dolor en el sitio de inyección, parestesia, debilidad muscular, neuropatía periférica, elevación del BUN y creatinina, hematuria, albuminuria, nefrotoxicidad. Colistimetato es considerado un nefrotóxico, es importante vigilar la función renal, sobre todo si hay otros fármacos nefrotóxicos concomitantes. Se recomienda vigilar durante la administración la aparición de síntomas de neurotoxicidad (mareos, confusión, parestesias, bloqueo neuromuscular, etc.).	
Incompatibilidades	Cefazolina, hidrocortisona.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 58 de 153	

43.- CLORURO DE SODIO 10 %

Electrolito

Presentaciones AM: 10 ml
Cada 100 ml de solución contiene Cloruro de Sodio 10 g (equivalente a 1710 mEq/l sodio y a 1710 mEq/l cloruro).

Indicaciones	Electrolitoterapia, terapia de rehidratación, érdida de líquido por vómitos excesivos y diarreas. Reposición de electrolitos asociados a reposición de volumen por vía parenteral.	
Contraindicaciones	Las soluciones de cloruro de sodio concentradas están contraindicadas en pacientes que presenten hipernatremia o retención de líquidos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5% - SRL	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	EV directa: Solo administrar bolo vía central. EV infusión intermitente y continua: diluido según necesidad y objetivo terapéutico.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Solo administrar bolo vía central. EV infusión intermitente: Administrar en 15 a 30 minutos. EV infusión continua: Administrar a 1 mmol/hora para prevenir el daño neurológico.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Evaluar periódicamente balance de fluidos, concentración de electrolitos y estado ácido-base. Algunos autores recomiendan no sobrepasar una corrección de 10 mEq/l en las primeras 24 horas y de 21 mEq/l en las primeras 48 horas.	
Incompatibilidades	Hidrocortisona, anfotericina B, tetraciclinas, cefazolina y sales de litio. Es incompatible con principios activos no solubles en la solución de cloruro de sodio, por eventual precipitación del principio activo, así como con medicamentos cuya estabilidad o solubilidad exijan un pH muy ácido o marcadamente alcalino. Antes de mezclar con otros medicamentos se deben comprobar las tablas de compatibilidad.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 59 de 153	

44.- CLORURO DE POTASIO 10 %

Electrolito

Presentaciones AM: 10 ml, contiene Cloruro de Potasio 1 g (equivalente a 13,41 mEq de K)

Indicaciones	Hipopotasemia con alcalosis metabólica o sin ella, en la intoxicación digitálica. Profilaxis de la hipopotasemia en diarrea severa, nefropatía con pérdida de potasio, etc.	
Contraindicaciones	Hiperpotasemia	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5% - SRL	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	Concentración máxima por vía periférica: 40 meq/L Concentración máxima por vía central: 80 meq/L	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR, entre 0,3 - 0,5 meq/kg/h, máximo 1 meq/kg/h.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Hiperkalemia (confusión, latidos cardíacos irregulares o lentos, entumecimiento u hormigueo en manos, pies y labios, sensación de falta de aire o dificultad para respirar; ansiedad inexplicada; cansancio o debilidad no habituales; debilidad o pesadez en las piernas). Por vía parenteral la incidencia de latidos cardíacos irregulares (arritmia) puede ser más frecuente, es la indicación clínica más temprana y se detecta fácilmente mediante ECG, mantener con monitorización electrocardiográfica durante infusión. Nunca administrar en bolo.	
Incompatibilidades	Anfotericina B, amikacina, diazepam, dobutamina, fenitoína, metilprednisolona, penicilina G. Solo incompatible en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 60 de 153	

45.- COTRIMOXAZOL (TRIMETROPRIM – SULFAMETOXAZOL)

Antibacteriano

Presentaciones AM: Cada 5 ml contiene 80 mg de trimetoprim 400 mg sulfametoxazol

Indicaciones	Infecciones del tracto urinario, neumonía por pneumocystis jiroveci. En combinación con otros agentes para el tratamiento de la toxoplasmosis.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a sulfamidas o al trimetoprim. Anemia megaloblástica por deficiencia de folatos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF, pero se recomienda usar SG5% por mejor estabilidad.	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	Infusión por ampolla: 5 ml en 125 ml 10 ml en 250 ml 15 ml en 500 ml de solvente	Estabilidad: T°A: 0,64 mg/ml → 6 horas (5 ml/125 ml SG5%). 0,8 mg/ml → 4 horas (5 ml/100 ml SG5%). 1,06 mg/ml → 2 horas (5 ml/75 ml SG5%). R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 60 – 90 min. Velocidad de administración en ML/HR	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar rash, prurito, fiebre, anemia megaloblástica, dermatitis exfoliativa, insuficiencia renal, náuseas, vómitos, trombocitopenia, neutropenia, leucopenia. La solución que se administra en pacientes con restricción de fluidos se debe inspeccionar por la posibilidad de cristalización. Evaluar siempre la posibilidad de precipitación, incluso puede ocurrir antes de los tiempos de estabilidad recomendados. Vigilar el hemograma y la función renal en tratamientos prolongados y sobre todo en pacientes con tratamiento con fármacos que posean toxicidad hematológica y renal.	
Incompatibilidades	Caspofungina, cisatracurio, foscarnet, fluconazol, linezolid, midazolam. Solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 61 de 153	

46.- DANTROLENO

Relajante Muscular

Presentaciones FAL: 20 mg

Indicaciones	Tratamiento de la hipertermia maligna.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco. En pacientes con disfunción hepática severa.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5% - API	
Reconstitución	60 ml de suero. La concentración final es de 0,333 mg/ml. Esta solución tiene una osmolalidad aproximada de $261 \pm 2,1$ mOsm/L.	Estabilidad: T°A: 6 hrs R: No
Dilución	No requiere.	
Administración	EV directa: Si. Cuando el paciente requiera tratamiento rápido. EV infusión intermitente: Si. Preferir este método si la urgencia lo permite. EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Mínimo en 3 minutos. EV infusión intermitente: mínimo en 1 hora.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Se puede observar diarrea, náuseas, hepatitis, mialgia, rash, somnolencia, confusión, disturbios visuales. Dantroleno es considerado un fármaco hepatotóxico, es importante vigilar la función hepática. La extravasación es muy irritante para los tejidos debido al alto pH. Examinar cuidadosamente la solución antes de administrar. Si llegara a precipitar o formar agregados, intentar re-disolver por agitación. Si no es posible, desechar la solución. El polvo para reconstituir contiene también manitol 3 gr (efecto diurético).	
Incompatibilidades	No mezclar con sales de calcio.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 62 de 153	

47.- DAPTOMICINA

Antibiotico Lipopeptido

Presentaciones FAL: 500 mg

Indicaciones	Infecciones por microorganismo sensibles como: infecciones complicadas de piel y partes blandas, bacteremias, endocarditis.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al medicamento	
Almacenamiento	Debe conservarse entre 2 y 8 °C.	
Sueros compatibles	SF – RL	
Reconstitución	10 ml SF (50 mg/ml)	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: 48 hrs
Dilución	100 – 250 ml de suero compatible, de acuerdo a la restricción de volumen.	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión directa: Se administra en 2 minuto, el medicamento reconstituido EV infusión intermitente: Administrar 30 minutos, el medicamento diluido	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Evitar la agitación vigorosa del frasco ampolla durante o después de la reconstitución para evitar la formación de espuma. Dejar reposar durante 10 minutos antes de reconstituir. Control con creatinfosfoquinasa (CPK), antes y durante el tratamiento con el antibiotico. Puede provocar reacciones de hipersensibilidad que pueden incluir anafilaxia, angioedema, erupción cutanea, dolor o presión en el pecho, taquicardia, fiebre, mareos.	
Incompatibilidades	Incompatible con diluyentes que contienen glucosa. No mezclar con otras soluciones intravenosas, si se utiliza la misma vía para diferentes medicamentos, se recomienda lavar la linea antes y después de la administración.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 63 de 153	

48.- DESMOPRESINA

Análogo de Vasopresina - Antidiurético

Presentaciones AM: 15 mcg/ml

Indicaciones	Diabetes insípida, enuresis nocturna, enfermedad de Von Willebrand, control de la hemorragia en ciertos tipos de hemofilia.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la desmopresina. No está indicado para el tratamiento de la hemofilia tipo A con niveles del factor VIII iguales o menores a 5%, para el tratamiento de hemofilia B, en pacientes que presentan anticuerpos contra el factor VIII. Hiponatremia.	
Almacenamiento	Debe conservarse entre 2 y 8 °C.	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	0,5 mcg/ml	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión directa: Se administra en 1 minuto. EV infusión intermitente: Administrar en 15 - 30 minutos.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Se puede observar somnolencia, cefalea, sofocos, confusión, dolor de pecho, palpitaciones, taquicardia, insomnio, agitación, convulsiones (en dosis usuales) náuseas, dolor en el lugar de inyección. Monitorizar presión arterial y frecuencia cardíaca, electrolitos, balance hídrico estricto. A las dosis recomendadas existe una alta frecuencia de hiponatremia y convulsiones. Usar con precaución en pacientes con aclaramiento de creatinina bajo 50 ml/minuto.	
Incompatibilidades	Incompatible con suero glucosado 5%. No mezclar con otras soluciones intravenosas.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 64 de 153	

49.- DEXAMETASONA

Glucocorticoide

Presentaciones AM: 4mg/ml

Indicaciones	Indicada en variadas patologías por su efecto antiinflamatorio, inmunosupresor. Terapéutica sustitutiva en el tratamiento de insuficiencia suprarrenal. Diagnóstico del síndrome de Cushing. Isquemia cerebral. Es de elección cuando se requiere un corticoide de acción prolongada.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco y cualquiera de sus componentes.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5 %	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	En dosis menor a 10 mg no requiere dilución. En dosis mayores a 10 mg diluir a 0,1–1 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 48 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Lentamente de 3 a 5 minutos EV infusión intermitente: Administrar de 15 a 30 minutos	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar edema, hipertensión, dolor de cabeza, intolerancia a la glucosa, hipokalemia, alcalosis, síndrome de Cushing, úlcera péptica, náuseas, vómitos, osteoporosis, cataratas, glaucoma, fracturas.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 65 de 153	

50.- DEXMEDETOMIDINA

Sedante - Analgésico

Presentaciones AM: 100 mcg/ml
MTZ: 400 mcg/100 ml

Indicaciones	Proporciona sedación y analgesia, sin depresión respiratoria.	
Contraindicaciones	Inestabilidad hemodinámica, bloqueo AV de segundo o tercer grado, bradicardia <50 latidos/min, enfermedad cerebrovascular grave o hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5% - SRL	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	4 mcg/ml Habitual: 400 UG/100 ML 800 UG/200 ML	Estabilidad: T°A: 48 hrs R: 14 días
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: NO	
Velocidad de la administración	EV directa: Infusiones muy rápidas pueden provocar bradicardia y arresto sinusal. EV infusión continua: La dosis de mantención es de 0,2-0,9 mcg/kg/h.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Para minimizar los efectos farmacológicos indeseables, no deberá administrarse en inyecciones en bolo programadas. Administrar el medicamento con una bomba de infusión. Se recomienda monitoreo electrocardiográfico (ECG) durante la administración. Alteraciones más comunes son hipotensión y bradicardia.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 66 de 153	

51.- DIAZEPAM

Benzodiazepina

Presentaciones	AM: 10 mg/2 ml	
Indicaciones	Manejo general de ataques de ansiedad, ataques de pánico, como sedación preoperatoria, anestesia liviana, tratamiento de estatus epiléptico, síndrome de abstinencia, relajante músculo esquelético.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco o a sus excipientes.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	1mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: V.O., V.R.	
Velocidad de la administración	EV directa: 1 mg/minuto. EV infusión continua: Se recomienda cambiar cada 6 horas para evitar el riesgo de precipitación. Velocidad de administración en ML/HR	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Flumazenil contraresta el efecto de los benzodiazepinas en caso de sobredosis. Se puede observar hipotensión, bradicardia, paro cardiorrespiratorio, somnolencia, confusión, mareos, disartria, excitación paradójica, flebitis, dolor en el lugar de inyección, visión borrosa, diplopía, disminución en la frecuencia respiratoria, apnea, laringo espasmo, en el uso prolongado puede aparecer dependencia física. La administración rápida puede provocar apneas, depresión respiratoria, hipotensión, glaucoma de ángulo estrecho. Puede ser muy irritante, sobre todo por vía intramuscular. Evitar las venas de pequeño calibre por el riesgo de tromboflebitis. Un 25 a 50% del diazepam en solución puede absorberse a los contenedores de plástico en una hora de contacto. Monitorizar función respiratoria cada 10 a 15 minutos por la posibilidad de intoxicación por el excipiente propilenglicol (provoca un síndrome de gasping). Entre los excipientes puede tener benzoato de sodio y alcohol bencílico. No se recomienda mezclar con otros medicamentos por riesgo de precipitación.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 67 de 153	

52.- DOBUTAMINA

Catecolamina - Agente estimulante beta adrenérgico

Presentaciones AM: 250 mg/5 ml

Indicaciones	Aumento de la contractibilidad del corazón en insuficiencia cardiaca aguda, como ocurre en shock cardiogénico e infarto de miocardio. Otras circunstancias en las que su actividad inotrópica puede ser útil en cirugía cardíaca y durante ventilación por presión positiva.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz. No congelar.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	2,5 mg/ml Habitual: 250 mg/100 ml 500 mg/200 ml	Estabilidad: T°A: 24 horas R: 48 horas
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: La indicación se expresará en: $\gamma(\mu\text{g})/\text{kg}/\text{min}$ Rango habitual 2-20 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar cefalea, mareos, náuseas, ansiedad, hipotensión, hipertensión, palpitaciones, taquiarritmias, extrasístoles ventriculares, angina, vómitos, neutropenia, trombocitopenia, anemia. Debe ser administrado en una vena de gran calibre, para evitar la extravasación. Se puede administrar por vía periférica, por vía exclusiva. Se utilizará de preferencia por CVC, junto con otras DVA, con llaves de tres pasos suficientes para realización del cambio. Compatible por la misma vía con amiodarona, atracurio, dopamina, epinefrina, labetalol, lidocaína, propofol, norepinefrina, milrinona, morfina, fentanilo, vecuronio. Si llegara a ocurrir extravasación pudiera provocar necrosis e isquemia tisular. Si la solución adquiere una coloración rosada, indica que hay una ligera oxidación, pero no se debe desechar. El cambio de solución se debe hacer cada 24 horas. Mantener monitorización electrocardiográfica continua, presión arterial invasiva en UCI.	
Incompatibilidades	Aciclovir, bicarbonato de sodio, anfotericina B, ampicilina, cefepime, cloruro de calcio, cloruro de potasio, diazepam, digoxina, fenitoina, fitomenadiona, foscarnet, fosfato de potasio, furosemida, gentamicina, gluconato de calcio, heparina, insulina (regular), midazolam, penicilina sódica, piperacilina/tazobactam, sulfato de magnesio, tiopental, verapamilo. Solo en mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 68 de 153	

53.- DICLOFENACO SODICO

Antiinflamatorio No esterooidal - Analgésico - Antipirético

Presentaciones AM: 75 mg/3 mL

Indicaciones	Alivio del dolor y la inflamación, antipirético.	
Contraindicaciones	En úlcera péptica, primer trimestre del embarazo, alteraciones coagulación, porfiria.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	0,6 mg/ml 75 mg/ 50ml -100 ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: 50ml - 100 ml suero, en 30 minutos. IM : IM profunda	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Dolor y ocasionalmente lesión tisular en el lugar de la inyección, cuando se administra por vía IM. Molestias gastrointestinales, como náuseas y diarreas, úlceras pépticas y hemorragias digestivas. Efectos sobre el SNC como cefaleas, vértigo, mareos, nerviosismo, somnolencia. Efectos hematológicos como anemia, trombopenia, neutropenia, eosinofilia y agranulocitosis.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 69 de 153	

54.- DOMPERIDONA

Antihemético - Antidopaminérgico periférico

Presentaciones AM: 10 mg/2 ml

Indicaciones	Tratamiento sintomático de las náuseas, vómitos y reflujo gastrointestinal.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco. Presencia de sangrado intestinal, prolactinoma, obstrucción mecánica o perforación digestiva.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	0.5 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	1 mg/10 ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Lentamente de 3 a 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar de 15 a 30 minutos.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Dolor abdominal, constipación o diarrea, urticaria La hiperprolactinemia es una reacción adversa frecuente, pudiendo cursar con galactorrea, amenorrea reversible y ginecomastia.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 70 de 153	

55.- DOPAMINA

Catecolamina – Vasopresor - Inótropo

Presentaciones AM: 200 mg/5 ml

Indicaciones	Tratamiento del shock que no responde a volumen, shock cardiogenico y distributivo.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco, fibrilación ventricular, feocromocitoma.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz.	
Sueros compatibles	SF –SG5% -SGL	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	4mg/ml Habitual: 400 mg/100 ml 800 mg/200 ml 1000 MG/ 250 ML	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: sa indicación se expresará en µg/kg/min Rango habitual: 3 a 20 ug/kg/min	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar cefaleas, disnea, palpitaciones, extrasístoles ventriculares, taquicardia supra ventricular, taquicardia ventricular, vasoconstricción periférica, náuseas, vómitos, diarrea, insuficiencia renal aguda, necrosis localizada por extravasación. Compatible en solución con atracurio, dobutamina, epinefrina, isoproterenol, lidocaína, norepinefrina, vecuronio. Debe ser administrado en una vena de gran calibre por CVC. Si la solución adquiere una coloración amarilla NO USAR, ya que hay una alta probabilidad de que se degrade por oxidación. No es estable en soluciones alcalinas. Evitar la suspensión abrupta ya que puede inducir hipotensión.	
Incompatibilidades	No mezclar en solución con ampicilina, anfotericina-B, furosemida, gentamicina, insulina cristalina ni soluciones alcalinas, tiopental. Bicarbonato de sodio produce rápida desactivación de la dopamina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 71 de 153	

56.-DROPERIDOL

Neuroléptico, Antiemético

Presentaciones AM: 5 mg/2ml

Indicaciones	Premedicación anestésica como neuroléptico, en neuroleptoanalgesia asociado a fentanyl.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al droperidol.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	0,2 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	IV directa: administra lentamente en 5 minutos, diluido en 20 cc de SF, SG5% IV intermitente: diluir una ampolla en 250 cc de SG5%, SF o RL pasar en 2 a 3 horas. Generalmente en bombas de infusión analgésicas asociado a tramadol y clonixinato de lisina.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Prolongación del intervalo QT en el ECG, hipotensión, taquicardia, ansiedad, síntomas extra piramidales, distonía, signos y síntomas pseudoparkinsonianos, alteraciones centrales en la regulación de la temperatura, sedación, alucinaciones, constipación, náusea, vómito.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 72 de 153	

57.- EFEDRINA 6%

Simpaticomimético –Inotropo

Presentaciones AM: 60 mg/ml

Indicaciones	Manejo del broncoespasmo, hipotensión y shock.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la epinefrina, arritmias cardíacas, glaucoma de ángulo cerrado, uso recurrente de otros simpaticomiméticos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SG 5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	1:1	Estabilidad: T°A: 6 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: SC	
Velocidad de la administración	IM: Inicio de respuesta en 10-20 min. IV directa: Diluir una AM en 19 cc, a razón de 3 mg por cc. Administrar en 5 min. IV continua: Diluir en 60 cc SF	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Angina, arritmias, elevación o disminución de presión sanguínea, palpitaciones, taquicardias, agitación, ansiedad, cefalea, insomnio, irritabilidad, anorexia, náuseas, vómitos, disuria, temblor, disnea.	
Incompatibilidades	Incompatibilidad con propofol, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 73 de 153	

58.- ERGOMETRINA MALEATO

Oxitócico

Presentaciones AM: 0,2 mg/ml

Indicaciones	Tratamiento de atonía o hemorragia uterina. Prevención y tratamiento de las hemorragias postparto.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco, en la inducción del trabajo de parto, amenaza de aborto espontáneo, hipertensión, insuficiencia renal o hepática, en pacientes con deficiencia de calcio, en caso de sepsis, para su uso rutinario en la expulsión de la placenta y durante la lactancia.	
Almacenamiento	Refrigerado entre 2 y 8°C	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	Diluir la dosis (normalmente media o una ampolla) en 5 ml de SF	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	IM: 0,2 mg, repetir hasta 5 veces, según necesidad cada 2 – 4 hrs. EV directa: En los casos urgentes, se puede administrar 0,2 mg vía IV lenta.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, cefalea, vértigo, dolor torácico, palpitaciones, bradicardia y otras arritmias cardíacas, infarto al miocardio, disnea y edema pulmonar. Hipertensión, tras la administración IV rápida. Reacciones de hipersensibilidad, incluido shock.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 74 de 153	

59.-ERTAPENEM

Antibiótico Carbapenémico

Presentaciones FA: 1 gr

Indicaciones	Indicado para el tratamiento de pacientes con infecciones moderadas a severas causadas por cepas susceptibles de microorganismos.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad conocida al fármaco u otros fármacos de la misma clase o en los pacientes que han demostrado reacciones anafilácticas a los betalactámicos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF -API	
Reconstitución	100 mg/ml	Estabilidad: T°A: No hrs R: No
Dilución	20 mg/ml	Estabilidad: T°A: 6 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente de 3 a 5 minutos. EV infusión intermitente: Administrar en no menos de 30 minutos. IM: la infusión IM debe ser administrada antes de 1 hr después de la reconstitución.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Fatiga, constipación, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, rash. Sólo se debe administrar ertapenem durante el embarazo si hay un beneficio que justifica el riesgo potencial para la madre y el feto.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos o soluciones que contengan dextrosa.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 75 de 153	

60.- ETOMIDATO

Inductor de Anestesia

Presentaciones AM: 20 mg/10 ml

Indicaciones	Inducción de la anestesia general e inducción de la anestesia rápida.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a etomidato.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG 5%	
Reconstitución	No requiere	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	No requiere	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: 10 ml/minuto	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Náuseas, vómito, dolor en el sitio de inyección, movimientos involuntarios de ojos. Diskinesia, mioclonia, hipotensión, apnea, hiperventilación, estridor, vómito, náusea, exantema, disminución de los niveles de cortisol. Se contraindica su uso en forma de perfusión prolongada por tener un efecto inhibitorio de la liberación de cortisol.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 76 de 153	

61.- FENILEFRINA 1%

Simpaticomimético - Vasopresor

Presentaciones AM: 1mg (10 mg/ml)

Indicaciones	Hipotensión inducida por fármacos, anafilaxia, shock.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la fenilefrina o a alguno de los excipientes. Pacientes en tratamiento con inhibidores del monoamino oxidasa o dentro de los 14 días después de haber interrumpido el tratamiento con este fármaco. Hipertensión grave. Hipertiroidismo.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF –SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	La dilución es 2,5 mg/ml Habitual: 40 mg/100 ml 80 mg/200 ml 100 mg/250 ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: SC	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: La indicación se expresará en ug/min Rango habitual: 30 a 180 ug/min	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Bradicardia refleja, taquicardia refleja, arritmias cardíacas, dolor anginoso, palpitaciones, paro cardíaco, hipertensión, hipotensión, rubor, dolor de cabeza, hemorragia cerebral, vértigo, disnea, edema pulmonar, vómitos, hipersalivación, dificultad en la micción, retención urinaria, sudoración, hormigueo transitorio, sensación de frío en la piel, alteraciones del metabolismo de la glucosa. No usar soluciones de color café o precipitado. La extravasación puede causar necrosis tisular.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 77 de 153	

62.- FENITOINA SODICA

Antiepiléptico

Presentaciones AM: 250 mg/5 ml

Indicaciones	En la prevención y tratamiento de ataques convulsivos. Manejo de convulsiones tónico clónico generalizadas.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco. Bradicardia, bloqueo cardiaco	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	1 - 10 mg/ml	Estabilidad: T°A: 4 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: SI IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Máximo 50 mg/minuto EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR. En pacientes mayores de 50 años o con antecedentes cardiovasculares no exceder los 20 mg/minuto.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Falta de apetito, cefaleas, mareos, nerviosismo transitorio, insomnio y alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y estreñimiento. Desarrollo de sensibilidad e hiperplasia gingival, en especial en pacientes más jóvenes. Una sobredosis puede causar hipotensión, coma y depresión respiratoria. Tras la administración IV puede producirse hipotensión y depresión del SNC, si es demasiado rápida, así como arritmias cardíacas y alteraciones de la conducta cardíaca. Irritación en el sitio de inyección, tromboflebitis. La monitorización mediante niveles es una herramienta muy útil para evaluar la seguridad y efectividad del producto. En caso de monitorizarse niveles plasmáticos es muy importante ser rigurosos con los tiempos y ritmos de administración del fármaco, así como con el registro de los horarios de extracción de muestras.	
Incompatibilidades	Amikacina, aminofilina, anfotericina-B, ciprofloxacino, cloruro de potasio, dobutamina, fenobarbital, heparina, linezolid, morfina, propofol.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 78 de 153	

63.- FENOBARBITAL

Barbitúrico - Anticonvulsivante

Presentaciones AM: 200 mg/ml

Indicaciones	Hipnótico de acción prolongada. Hiperexcitabilidad psicomotriz. Anticonvulsivante preventivo de crisis epilépticas.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco. Disfunción hepática importante, porfiria, disfunción respiratoria importante.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	10 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	Bolo: No exceder 60 mg/min. Infusión intermitente: Infundir sobre 10 a 30 min.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar hipotensión, arritmias, bradicardia, tromboflebitis, letargo, náuseas, vómitos, rash, oliguria, laringoespasma, apnea, depresión respiratoria, hipotermia, excitación del SNC. Evitar la extravasación peri-vascular y la administración intraarterial debido a la alcalinidad de la solución. La monitorización mediante niveles es una herramienta muy útil para evaluar la seguridad y efectividad del producto. En caso de monitorizarse niveles plasmáticos es muy importante ser rigurosos con los tiempos y ritmos de administración del fármaco, así como con el registro de los horarios de extracción de muestras.	
Incompatibilidades	Anfotericina B, adrenalina, clindamicina, clorpromazina, dopamina, efedrina, fenitoína, hidralazina, hidrocortisona, insulina, noradrenalina, penicilina G, ranitidina, succinilcolina, tiamina, vancomicina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 79 de 153	

64.- FENOTEROL

Broncodilatador – Tocolítico - Agonista beta adrenérgico

Presentaciones AM: 0,5 mg/10 ml

Indicaciones	En el tratamiento del asma bronquial, broncoespasmo reversible y otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias como bronquitis y enfisema pulmonar, bronquiectasia e infecciones pulmonares. Amenaza de aborto prematuro.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	2,5 mg (sin diluir) en 50 cc.	Estabilidad: T°A: 6hrs en SG5% 12hrs en SF R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: Inhalatoria (nebulización)	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: 0,1 - 0,3 mcg /kg/min.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Se puede observar un ligero temblor distal de extremidades e inquietud. Pueden aparecer palpitaciones, taquicardia, mareos, cefaleas, en especial en pacientes hipersensibles a los beta-agonistas. En algunos casos se ha informado tos o broncoconstricción paradójica. Puede producir una marcada hipokalemia, por lo tanto, debe tenerse en cuenta en el asma severa ya que sus efectos cardíacos pueden potenciarse con el uso de xantinas, esteroides, diuréticos o por la hipoxia; en tal situación se debe monitorear el potasio sérico. Administrar con cuidado en pacientes diabéticos descompensados ya que puede exacerbar la hiperglicemia. No debe utilizarse si se observan partículas en la solución reconstituida. La descoloración es sinónimo de descomposición.	
Incompatibilidades	Es inestable en soluciones acidas, pero mantiene estabilidad en soluciones neutras y alcalinas. No mezclar ni pasar juntos por vía con otros fármacos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 80 de 153	

65.- FENTANILO

Analgésico y Anestésico Opioide

Presentaciones	AM: 0,5 mg/10 ml AM: 0,1 mg /2 ml (solo pabellon)	
Indicaciones	Analgesia y suplemento de la anestesia. De mantención sólo en casos particulares de ventilación mecánica y analgesia refractaria.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco, incremento de la presión intracraneal, depresión respiratoria severa, íleo paralítico, insuficiencia renal o hepática.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF –SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	La dilución es 10 ug/ml, con una relación es 1:100 Habitual: 1 mg/ 100 ml 2,5 mg /250 ml 3 mg/ 300 ml 6 mg/ 600 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: Epidural	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar de 3 - 5 minutos según respuesta. Dosis mayores de 5 ug/kg deben ser dadas en 5 - 10 minutos. Infusión continua: La indicación se expresará en:ug/Kg/hora. Rango habitual: 0.5 a 3,6 ug/kg/hr.No sobrepasar de 5 ug/kg/hora por alto riesgo de efectos adversos.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	La sobredosis es revertida con Naloxona. Depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, rigidez muscular. Los efectos pueden reducirse si se administra en inyección IV lenta. Mantener monitorización electrocardiográfica. Al administrar en bolo rápido, provoca broncoespasmo y laringoespasmo. Es compatible con atracurio, dobutamina, dopamina, epinefrina, midazolam, milrinona, norepinefrina, pancuronio, rocuronio, vecuronio, morfina, lorazepam, ketamina.	
Incompatibilidades	Incompatibilidades en soluciones ácidas. No mezclar con barbitúricos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 81 de 153	

66.- FILGRASTIM

Factor estimulante de Granulocitos - Inmunomodulador

Presentaciones JG: 300 ug/0,5 ml
AM: 300 ug/1 ml

Indicaciones	En la profilaxis y tratamiento de la neutropenia en pacientes tratados con fármacos mielosupresores y para reducir el período de neutropenia en pacientes sometidos a trasplante de médula ósea.	
Contraindicaciones	Contiene sorbitol como excipiente, por lo que debe informarse a los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.	
Almacenamiento	Refrigerado entre 2 - 8°C. No congelar.	
Sueros compatibles	SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	No diluir a concentraciones menores a 2 µg/ml	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: SC. No diluir	
Velocidad de la administración	Las dosis se expresan en µg o en UI; 10 µg equivalen a 1 millón de UI.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Artromialgias y disuria. Reacciones de hipersensibilidad. Dolor óseo y dolor osteomuscular. Esplenomegalia, trombocitopenia, anemia, epistaxis, cefalea, diarrea y vasculitis cutánea.	
Incompatibilidades	No diluir en SF, por riesgo de precipitación. Anfotericina-B, cefepime, cefoperazona/sulbactam, cefotaxima, ceftriaxona, clindamicina, etoposido, fluoracilo, furosemida, heparina, metilprednisolona, metronidazol, piperacilina/tazobactam	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 82 de 153	

67.- FITOMENADIONA

Antihemorrágico - Vitaminoterapia

Presentaciones AM: 10 mg/ml

Indicaciones	Hemorragia o riesgo de hemorragia por hipoprotrombinemia de diferente etiología. Prevención de hemorragias en el recién nacido.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente. No refrigerar.	
Sueros compatibles	SF –SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	1 - 2 mg/ml.	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: V.O. (la misma ampolla)	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar en 2-3 min. EV infusión intermitente: Administrar en 15-30 min. (Recomendada)	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar mareos, sudoración profusa, hipotensión, disnea y cianosis. Dolor y tumefacción en el sitio de inyección. Se han descrito muchas reacciones adversas como anafilaxia asociadas a la administración E.V. muy rápida, por lo que se recomienda su administración intermitente. Las ampollas de Konakion no deben administrarse por vía intramuscular, puesto que esta vía puede actuar de depósito y la liberación continua de vitamina K1 causaría dificultades para restablecer el tratamiento anticoagulante. Las ampollas pueden ser usadas para administración oral. En el momento de su uso, el contenido de la ampolla ha de estar claro. Si se almacena el producto en condiciones inadecuadas, puede enturbiarse la solución o producirse la separación de fases. En tal caso, no debe utilizarse la ampolla.	
Incompatibilidades	Ampicilina, dobutamina, fenitoína. No utilizar con otros medicamentos por la misma vía.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 83 de 153	

68.-FLUCONAZOL

Antifúngico. Derivado azólico

Presentaciones MTZ: 200 mg/100 ml

Indicaciones	Infecciones por candida spp y criptococcus	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente. No refrigerar.	
Sueros compatibles	No aplica	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	No requiere. Solución a una concentración final de 2 mg/ml.	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	Infusión intermitente: Infundir sobre 1 hr (200mg/hr).	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Cefalea, mareos, astenia, disnea, arritmia, taquicardia, rash, alopecia, necrosis tóxica epidérmica, síndrome de Stevens-Johnson, hipercolesterolemia, hipertigliceridemia, hipokalemia, ginecomastia, trombocitopenia, hepatitis, colestasis, incremento de enzima hepáticas e incremento de la fosfatasa alcalina.	
Incompatibilidades	Anfotericina B, , cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, clindamicina, cotrimoxazol, diazepam, furosemida, gluconato de calcio, haloperidol, imipenem, piperacilina/tazobactam.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 84 de 153	

69.-FLUMAZENIL

Antagonista de los Benzodiazepinas

Presentaciones AM: 0,5 mg/5 ml

Indicaciones	Reversión de la sedación por benzodiazepinas empleadas en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos de corta duración. Para el tratamiento específico de la intoxicación por sobredosis de benzodiazepina. Como una medida de diagnóstico en un estado de inconsciencia de origen desconocido para descartar o confirmar la participación de benzodiazepinas en el cuadro o diferenciarlo de otras drogas. Reversión de la sedación mantenida con benzodiazepina, en pacientes bajo ventilación mecánica.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al flumazenil.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5% - SRL	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	No requiere.	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Bolo 15 segundos.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Puede producir hipertensión, hipotensión, arritmias, debilidad, bradicardia, taquicardia, extrasístoles ventriculares, sensación de calor, convulsiones generalizadas, náuseas, vómitos. Monitorizar frecuencia respiratoria, presión arterial, frecuencia cardiaca, nivel de conciencia, oximetría de pulso. La administración de su dosis total en forma rápida puede producir junto con la recuperación de la conciencia un estado de ansiedad, palpitaciones, de allí su administración en dosis parciales progresivas. Estos efectos desaparecen espontáneamente.	
Incompatibilidades	No hay estudios al respecto, se recomienda administrar solo, lavando acceso venoso antes y después de su administración.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 85 de 153	

70.- FUROSEMIDA

Diurético de asa

Presentaciones AM: 20 mg/ml

Indicaciones	Tratamiento de edema de origen cardíaco, hepático o renal, hipertensión arterial, hipercalcemia. Oliguria secundaria a insuficiencia renal.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la furosemida, sulfonilureas. Anuria, pacientes con coma hepático o en estados severos de depleción de electrolitos e hipovolemia	
Almacenamiento	Temperatura ambiente. No refrigerar.	
Sueros compatibles	SF – SG5% - SRL	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	1 mg/ml Habitual: 100 mg / 100 ml 200 mg / 200 ml 250 mg / 250 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No	
Velocidad de la administración	EV directa: 1 - 2 minutos. EV infusión continua: La indicación se expresará en mg/hr. Rango habitual: 5 a 20 mg/ hr Administrar según objetivos y respuesta clínica	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Mezcla en infusión no requiere protección de luz, si la dosis minuto es menor de 250 mg. Se puede observar mareo, hipokalemia, urticaria, hiponatremia, náuseas, pancreatitis, diarrea, anemia, trombocitopenia, hiperuricemia, nefritis intersticial, fotosensibilidad, hipotensión ortostática, hipotensión asociada a aumento de diuresis. El sobrepasar las recomendaciones de velocidad de infusión eleva el riesgo de ototoxicidad. Es compatible con albumina 20%, albumina 5%, aminofilina, heparina, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, gluconato de calcio, lidocaína, ampicilina, dexametasona, meropenem, ranitidina, penicilina-G, fentanilo, piperacilina, cefepime, ceftazidima. El efecto adverso más común es el desbalance electrolítico con hiponatremia, hipokalemia y alcalosis causada por prolongada diuresis, monitorizar electrolitos. No utilizar si se torna de color amarillo. Al refrigerarla puede precipitar o se puede cristalizar, esto se contrarresta al dejarla a temperatura ambiente sin alterar su estabilidad.	
Incompatibilidades	Soluciones ácidas. Ácido ascórbico, amikacina, amiodarona, caspofungina, cisatracurio, clorpromazina, ciprofloxacino, diazepam, dopamina, dobutamina, doxorubicina, epinefrina, filgastrim, fluconazol, gentamicina, idarubicina, labetalol, metoclopramida, midazolam, milrinona, morfina, ondansetron, petidina, vecuronio, vinblastina, vincristina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 86 de 153	

71.- FOSFATO MONOPOTÁSICO 15%

Electrolito

Presentaciones AM: Fosfato mono potásico 15%/10 ml
Cada 10 ml proporciona: Potasio 11.02 mEq; Fosfato 11.02 mEq.

Indicaciones	Hipofosfemia de cualquier origen.	
Contraindicaciones	No debe administrarse a pacientes con insuficiencia renal severa o hiperfosfemia.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	Vía central: 40 mEq de potasio/100 ml Vía periférica: 10 mEq de potasio/100 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar en 1 hora EV infusión continua: Administrar según indicación medica	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	La excesiva administración de fosfato particularmente por vía IV puede causar hiperfosfemia, esto a su vez conduce al desarrollo de hipocalcemia y calcificación ectópica debido a la precipitación de fosfato de calcio. Otras reacciones adversas que se pueden presentar son el tétano hipocalcémico, hipotensión, taquicardia, fiebre, edema e insuficiencia renal aguda. El tratamiento de los efectos adversos consiste en la discontinuación del fosfato y aplicar medidas de soporte o corregir las alteraciones de las concentraciones séricas de los electrolitos, especialmente calcio. Es necesario a través del tratamiento con el monofosfato potásico, monitorizar la concentración de potasio, calcio y fosfato.	
Incompatibilidades	No debe administrarse en forma concomitante con sales de aluminio, calcio o magnesio.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 87 de 153	

72.- GAMAGLOBULINA HUMANA

Inmunoglobulina

Presentaciones	FA: 5 gr/50 ml	
Indicaciones	Terapia de reposición en síndrome de inmunodeficiencia primaria, inmunomodulación, síndrome de Guillain Barre.	
Contraindicaciones	Reacción alérgica a la inmunoglobulina G y a otras proteínas provenientes del plasma humano, pacientes con falla renal y/o fallas cardíacas. Frente a reacciones de hipersensibilidad de tipo inflamatorio, interrumpir la administración.	
Almacenamiento	Mantener a menos de 25°C. No congelar	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	No requiere.	Estabilidad: T°A: Usar inmediatamente R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: SI IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar en a lo menos 1 hora (2 ml/minuto) EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	La administración IV rápida mayor a 2ml/min, puede provocar reacciones inflamatorias desde leves a graves y alteraciones en la presión sanguínea. Estas reacciones pueden evidenciarse dentro de los 30 a 60 minutos e incluye fiebre, náuseas, vómitos, rubor, mareos, precordalgia, disnea, taquicardia. Observar y controlar signos vitales durante la administración. Desechar el contenido no utilizado debido al riesgo de contaminación bacteriana.	
Incompatibilidades	Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos o soluciones intravenosas. Debe administrarse utilizando una vía intravenosa diferente.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 88 de 153	

73.- GENTAMICINA

Antibiótico Aminoglucósido

Presentaciones AM: 80mg/2ml

Indicaciones	Infecciones por bacterias sensibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la gentamicina u otros aminoglicósidos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF , SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	10 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: Intratecal	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 30 - 60 minutos	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Neurotoxicidad, ototoxicidad, nefrotoxicidad. Bloqueo neuromuscular, depresión respiratoria y parálisis muscular. Reacciones de hipersensibilidad, vómito, náuseas, estomatitis y trastornos hepáticos. Es importante respetar los tiempos de administración debido al alto riesgo de reacciones adversas cuando la infusión es muy rápida. La inyección IM se debe hacer en un musculo grande.	
Incompatibilidades	No administrar simultáneamente con otros aminoglicósidos, vancomicina, cefalosporinas, ciclosporina, cisplatino y fudarabina. Incompatible con anfotericina-B, ampicilina, cefazolina, clindamicina, cefepime, fenitoina, furosemida, heparina, propofol.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 89 de 153	

74.- HALOPERIDOL

Neuroléptico – Antipsicótico - Sedante

Presentaciones AM: 5mg /2ml

Indicaciones	Tratamiento de la psicosis, entre ellas la esquizofrenia.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al haloperidol, estado comatoso, depresión del SNC producida por el alcohol u otros medicamentos depresores, enf. de Parkinson, lesión de los ganglios basales.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	1 a 5 mg/ml Según vía de administración	Estabilidad: T°A: 8 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente de 1ml/min EV infusión intermitente: Administrar en de 30 a 60 minutos EV infusión continua: Administrar lentamente a no más de 10 ml/h	
Dializable		
Observaciones - RAM	Puede causar hipotensión, excesiva sedación. Reacciones extrapiramidales (distonía), euforia, letargia, agitación, insomnio, ansiedad, taquicardia	
Incompatibilidades	Anfotericia-B, cefepime, fluconazol, heparina, ketorolaco, piperacilina/tazobactam.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 90 de 153	

75.- HEPARINA

Anticoagulante

Presentaciones FA: 25.000 U.I./5ml

Indicaciones	Profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa y la embolia pulmonar. Puede emplearse también como anticoagulante en la cirugía extracorpórea y procesos de diálisis.	
Contraindicaciones	Pacientes con hipersensibilidad al medicamento, trombocitopenia severa, sospecha de hemorragia intra cerebral, hipotensión severa, endocarditis bacteriana, hemorragia incontrolable (al no ser secundaria a CID).	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	100 U/ml Habitual: 10 KU/100 ML 20 KU/ 200 ML 25 KU/250 ML KU: KILO UNIDADES, 1000 U	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: S.C.	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: La indicación se expresará en U/hr. Rango habitual: 300 a 1200 U/hr	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se inactiva con la protamina (antídoto). Se puede observar dolor de cabeza, urticaria, náusea, vómito, hemorragia, trombocitopenia, escalofríos, fiebre, necrosis en tejido subcutáneo (no frotar sitio de punción). Se debe monitorizar recuento de plaquetas, signos de sangrado, hemoglobina, hematocrito. La administración crónica y en dosis elevadas puede producir supresión de la síntesis de aldosterona, alopecia y priapismo.	
Incompatibilidades	No debe ser mezclado con doxorubicina, droperidol, ciprofloxacino o mitoxantrona porque precipitan.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 91 de 153	

76.- HIDROCORTISONA

Corticoide

Presentaciones FAL: 100 mg
FAL: 500 mg

Indicaciones	Insuficiencia adrenocortical, inmunosupresor, inflamación y desordenes alérgicos, asma y shock.	
Contraindicaciones	En infecciones sistémicas fúngicas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5% - SGL	
Reconstitución	50 mg/ml	Estabilidad: T°A: 3 días R: 3 días
Dilución	1 - 5 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV infusión directa: Administrar en 3 - 5 minutos la concentración de 50 mg/ml y sobre 10 minutos si la dosis es mayor de 500 mg. EV infusión intermitente: Administrar en al menos 20 – 30 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar dolor de cabeza, hipertensión, edema, insomnio, dermatitis, hipokalemia, hiperglicemia, síndrome de Cushing, ulcera péptica, inmunosupresión, hipertensión endocraneana. Debido a su alto metabolismo hepático son necesarios ajustes en pacientes con insuficiencia hepática. Usar con precaución en pacientes con hipertiroidismo, cirrosis, colitis ulcerativa, hipertensión, osteoporosis, tromboflebitis, ulcera péptica, diabetes, infecciones activas.	
Incompatibilidades	Aminofilina, bleomicina, ciprofloxacino, colistimetato, diazepam, efedrina, idarrubicina, midazolam, fenitoina, fenobarbital.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 92 de 153	

77.- HIDROXILO FERRICO EN COMPLEJO C/SACAROSA

Antianémico parenteral

Presentaciones AM: 100 mg/5 ml

Indicaciones	Indicado en todos los casos de deficiencias de hierro, en los cuales es necesaria una sustitución rápida y segura del mineral. En deficiencia funcional de hierro durante terapia con Eritropoyetina.	
Contraindicaciones	Anemias no causadas por deficiencias de hierro (por ej.: anemia hemolítica). Alteraciones en el uso del hierro o sobrecarga del mismo (por ej.: hemocromatosis, hemosiderosis). Cirrosis hepática descompensada. Hepatitis infecciosa. Pancreatitis crónica.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	Sólo SF	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	1 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: 12 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar en al menos 30 minutos.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Ocasionalmente puede ocurrir hipotensión, dolor articular, cefalea, alteraciones abdominales, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas, flebitis en el sitio de la inyección. Síntomas y tratamiento de dosis excesivas: En caso de intoxicación o sobredosis puede ocurrir una sobrecarga aguda de hierro, la cual se manifiesta como hemosiderosis. Evitar la sobrecarga de Hierro cuando la anemia que no responde al tratamiento ha sido incorrectamente diagnosticada como anemia por deficiencia de Hierro. Asimismo, en casos de sobrecarga de hierro en pacientes que han sido tratados como una talasemia (vale decir, con un agente quelante del Hierro).	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos ni con soluciones de glucosa	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 93 de 153	

78.- IMIPEMEN + CILASTATINA

Antibacteriano. Carbapenémico asociado a inhibidor de dihidropeptidasas.

Presentaciones FA: 500 mg

Indicaciones	Tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos sensibles.	
Contraindicaciones	Individuos con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - G5%	
Reconstitución	25 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	5 mg/ml	Estabilidad: T°A: 4 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Dosis menores o iguales a 500 mg imipenem: 15 - 30 minutos. Dosis mayores a 500 mg de imipenem: 40 - 60 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar rash, prurito, urticaria, eritema multiforme, síndrome de Stevens - Johnson, angioedema, candidiasis, fiebre, reacciones anafilácticas, náuseas, vómitos, diarrea, gastroenteritis, dolor abdominal, colitis hemorrágica y pseudomembranosa, eosinofilia, leucopenia, neutropenia, incluyendo agranulocitosis, trombocitopenia, trombocitosis, disminución de la hemoglobina y prolongación del tiempo de protrombina. Aumentos de las transaminasas, la bilirrubina y/o la fosfatasa alcalina, hepatitis, aumento de la creatinina, BUN, actividad mioclonia, trastornos psíquicos, incluyendo alucinaciones, estados confusionales o convulsiones y parestesias, eritema, dolor en el lugar de administración, tromboflebitis. Al reconstituir, agitar durante al menos 2 minutos hasta obtener una solución clara que puede ser incolora o amarillenta.	
Incompatibilidades	Alopurinol, anfotericina B, bicarbonato de sodio, etoposido, filgastrim, fluconazol, gemcitabina, lorazepam, midazolam.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 94 de 153	

79.- INSULINA NPH

Hipoglucemiante - Insulina humana isófona (NPH) de acción intermedia

Presentaciones FA: 10 ml (100 UI/ml)

Indicaciones	Tratamiento de la diabetes mellitus.
Contraindicaciones	Hipoglucemia, hipersensibilidad a la Insulina humana.
Almacenamiento	Refrigerado entre 2°C - 8°C. No congelar Una vez abierta es estable 6 semanas a < 25°C y 4 semanas a <30°C
Sueros compatibles	No aplica
Reconstitución	No requiere.
Dilución	No requiere.
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: No Otras vías: SC
Velocidad de la administración	Se inyecta generalmente en el muslo, también puede utilizar la pared abdominal, la región glútea y la región deltoides.
Dializable	No
Observaciones - RAM	Reacción de hipersensibilidad local (enrojecimiento, inflamación y picazón en el lugar de la inyección). En el lugar de inyección puede producirse lipodistrofia como consecuencia de la falta de rotación.
Incompatibilidades	No hay datos

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 95 de 153	

80.- INSULINA RÁPIDA

Hipoglucemiante de acción rápida

Presentaciones FA: 10 ml (100 UI/ml)

Indicaciones	Tratamiento de la diabetes mellitus Descompensaciones agudas: síndrome hiperosmolar o en la cetoacidosis.	
Contraindicaciones	Hipoglucemia, hipersensibilidad a la insulina humana.	
Almacenamiento	Refrigerado entre 2°C - 8°C. No congelar Una vez abierta es estable 6 semanas a < 25°C y 4 semanas a <30°C	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	100 UI/100 ml	Estabilidad: T°A: 18 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: SC	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: la indicación se realizará en UI/hr, a la velocidad que indique el protocolo local o el medico a cargo y se modificará según niveles de glicemia objetivo.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	En bomba de infusión continua debe cambiarse la bajada cada 3 días o según norma intrahospitalaria vigente. Una vez preparada la solución cebar la bajada con insulina ya diluida antes de ser administrada, de manera que se logre adsorber por las paredes de la bajada. La hipoglucemia es el efecto más común de las insulinas. Reacciones alérgicas, reacción en el sitio de inyección, lipodistrofia, prurito, rash.	
Incompatibilidades	Aminofilina, bicarbonato de sodio, fenitoina, fenobarbital. Se recomienda por vía exclusiva.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 96 de 153	

81.- ISOPROTERENOL

Simpaticomimético – Estimulante Adrenoceptor

Presentaciones AM: 1 mg/5ml

Indicaciones	Bloqueo cardíaco, bradicardia severa, obstrucción de la vía aérea reversible y shock cardiogénico o endotóxico.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al isoproterenol o algún componente de la formulación, o a otras aminas simpaticomiméticas. Angina, preexistencia de arritmias ventriculares, taquicardia o bloqueo AV causada por intoxicación por digitálicos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5% - SGL – SRL	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	EV directa: Diluir 1ml a 10ml con SF (20 µg/ml). Infusión continua: 2mg/500ml Mínimo volumen: 1mg/100 ml SG5%	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: SC	
Velocidad de la administración	EV directa: Inyección rápida. EV infusión intermitente: solución diluida, iniciar con 0.02 mg a 0.06 mg, luego con dosis de 0.01 a 0.2mg. Infusión continua: Rango de 2 a 20 µg /min.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Rubor facial, temblor suave, nerviosismo, vómitos, cefalea, taquicardia, edema pulmonar, angina. Monitorizar con electrocardiograma, electrolitos y signos vitales. Corregir hipovolemia antes de la administración en pacientes hipotensos. Evitar su administración en pacientes con taquiarritmias y en taquicardia o bloqueo cardíaco debido a la intoxicación por digitálicos.	
Incompatibilidades	Soluciones alcalinas, aminofilina, furosemida, bicarbonato de sodio.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 97 de 153	

82.- KETAMINA

Anestésico general No barbitúrico de corta duración

Presentaciones FA: 500 mg/10 ml

Indicaciones	Inducción y mantención de la anestesia general. Analgesia y sedación, para procedimientos de diagnósticos o intervenciones quirúrgicas breves. Estatus epileptico refractario.	
Contraindicaciones	Eclampsia, preeclampsia, insuficiencia cardiaca, cirugía intraocular, HIC, enfermedades cerebrovasculares.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	50 mg/ml máxima concentración para administración en bolo. Habitual: 400 MG/ 100 ML 800 MG/200 ML 1000 MG/ 250 ML	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: No administrar en menos de 1 min. EV Infusión continua: La velocidad de infusión será en UG/KG/MIN.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Hipertensión, taquicardia, hipotensión, bradicardia, incremento de flujo sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracraneana, aumento de la tasa metabólica, aumento de la presión intraocular, aumento de tono muscular, fasciculaciones, sialorrea, vómitos, náuseas postoperatorias, diplopía, nistagmus, depresión respiratoria, dependencia en uso prolongado, laringoespasma, disminución de broncoespasmo, apnea en infusiones rápidas. Utilizar con precaución en pacientes con elevación de la presión intracraneana, hipertensión, aneurismas, tirotoxicosis, angina de pecho, insuficiencia cardiaca congestiva, trastornos psicóticos. Se recomiendan utilizar asociando benzodiacepinas en pacientes pediátricos y adolescentes, su uso sin esta asociación provoca alucinaciones.	
Incompatibilidades	Diazepam, fenobarbital, furosemida, lorazepam, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 98 de 153	

83.- KETOPROFENO

Analgésico – Antipiretico - Antiinflamatorio

Presentaciones FAL: 100 mg

Indicaciones	Artritis reumatoidea, osteoartritis, dolor leve a moderado, dismenorrea, inflamación no reumática	
Contraindicaciones	Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco o a otros antiinflamatorio no esteroideos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	FAL con 5 ml suero	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	1 a 2 mg/ ml Habitual: 100 mg/100 ml 300 mg/ 250 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar en 30 minutos. EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR, rango habitual de 10 a 12 ml/hr	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar edema, náuseas, irritación gastrointestinal, cefaleas, constipación, problemas para dormir, visión borrosa, fotosensibilidad, rash cutáneo, hematuria, escalofríos, urticaria, confusión, melena, hematemesis. La administración directa (en bolo) puede provocar flebitis y dolor en sitio de inyección, es muy venoiritante. Existen formulaciones en ampolla de uso exclusivo intramuscular. Usar con precaución en anemia, asma, función cardíaca comprometida, hipertensión, hemofilia u otros problemas hemorrágicos; disfunción hepática, úlcera péptica, colitis ulcerosa, disfunción renal, síntomas de broncoespasmo.	
Incompatibilidades	No hay datos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 99 de 153	

84.- KETOROLACO

Analgésico - Antiinflamatorio.

Presentaciones AM: 30 mg/ml

Indicaciones	Dolor post traumático y de músculo esquelético, cólicos renales y biliares, dolor post operatorio y dolores crónicos en general.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al medicamento, aspirina, antiinflamatorio no esteroideos. No debe usarse en pacientes con úlcera péptica activa, pólipos nasales, angioedema. No usar por más de 5 días.	
Almacenamiento	Protegido de la luz, a temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	2 a 6 mg/ml. Habitualmente 90 mg/250 ml	Estabilidad: T°A: 48 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: 1- 5 minutos, no administrar en menos de 15 segundos. EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR, Administrar de 10 a 20 ml/hr.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	En general es bien tolerado, puede presentar raramente alteraciones gastrointestinales, cefalea, mareos, vómitos, diarrea, prurito, rash cutáneo, dolor en sitio de inyección, edema, hipertensión. Estos efectos son reversibles al suspender el tratamiento. Utilizar con precaución en pacientes con daño renal o falla hepática.	
Incompatibilidades	Carbamazapina, heparina, fenitoina, furosemida, metotrexato, morfina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 100 de 153	

85.- LABETALOL

Vasodilatador. Alfa y beta bloqueador adrenérgico

Presentaciones AM: 100mg/20 ml

Indicaciones	Tratamiento para hipertensión leve a grave. Emergencias hipertensivas.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco. Bloqueo AV de segundo o tercer grado, shock cardiogénico, otros estados asociados a hipotensión prolongada y grave o bradicardia grave. Los beta bloqueadores, incluso aquéllos con cardioselectividad aparente, no deben usarse en pacientes con asma o historia de enfermedad obstructiva de las vías aéreas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	1 a 5mg/ml Habitual: 100 MG/ 100 ML 200 MG/200 ML 250 MG/ 250 ML	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No	
Velocidad de la administración	EV directa: 2 - 3 minutos. Reservar solo para casos especiales. EV infusión continua: La indicación será en mg/ hr. Iniciar a 10 mg/hr y ajustar según respuesta.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Hipotensión ortoestática, fatiga, cefalea, náuseas, disnea, congestión nasal, beta bloqueo cardiaco. Utilizar vía de administración exclusiva. No detener infusión abruptamente en pacientes con cardiopatía isquémica. Es conveniente monitorear la presión arterial y frecuencia cardíaca durante la infusión, en UCI. La función respiratoria debe ser observada, particularmente en los pacientes con cualquier deterioro conocido.	
Incompatibilidades	Anfotericina-B, bicarbonato de sodio, furosemida, cefoperazona/sulperazon, ceftriaxona, heparina, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 101 de 153	

86.- LANATOCIDO C

Antianginoso – Antiarrítmico – Cardiotónico - Glucósido cardíaco.

Presentaciones	AM: 0,4 mg/2ml
Indicaciones	Insuficiencia cardíaca aguda. Aleteo auricular y fibrilación, taquicardia paroxística asociada con insuficiencia cardíaca manifiesta o latente. Todas las formas y grados de insuficiencia cardíaca crónica. Insuficiencia cardíaca latente y en pacientes preoperatorios.
Contraindicaciones	Bloqueo auriculoventricular completo y bloqueo grado 2. Bradycardia sinusal excesiva, especialmente cuando se asocia con Síndrome de Adams Stokes.
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Sueros compatibles	SF – SG5%
Reconstitución	No requiere
Dilución	No requiere
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: No
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar en no más de 5 minutos IM: Presenta mayor malestar local, efecto lento y biodisponibilidad errática.
Dializable	Si
Observaciones - RAM	Anorexia, náuseas, vómitos, alteración del segmento ST, prurito, urticaria, confusión, trastorno de la frecuencia cardíaca, conducción y ritmo.
Incompatibilidades	Sin datos

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 102 de 153	

87.- LEVETIRACETAM

Anticonvulsivantes

Presentaciones	FA: 500 mg/5ml	
Indicaciones	Tratamiento de las convulsiones.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al levetiracetam, angioedema y anafilaxia	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5% -SRL	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	5 -15 mg/ml 500 mg/100 ml	Estabilidad: T°A: 4 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: SI IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar en a lo menos 15 min. EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Monitorizar la aparición o el empeoramiento de la depresión, pensamientos suicidas o cualquier cambio inusual en el estado de ánimo o el comportamiento. Las reacciones adversas más comunes son: neurosis, somnolencia, astenia, dolor de cabeza, nasofaringitis, nerviosismo, comportamiento anormal, comportamiento agresivo, agitación, ansiedad, apatía, despersonalización, depresión, fatiga, la hostilidad, la actividad muscular hipercinéticos, trastornos mentales, trastornos de la personalidad, inestabilidad emocional, irritabilidad y cambios de humor.	
Incompatibilidades	Fenitoína sódica	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 103 de 153	

88.- LEVOFLOXACINO

Antibiótico. Fluorquinolona

Presentaciones MTZ: 500 mg/100 ml

Indicaciones	Infecciones por gérmenes sensibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	No aplica	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	No requiere.	Estabilidad: T°A: Una vez abierto, 3 hrs a fin de impedir contaminación bacteriana. R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar en 60 a 90 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Durante la infusión puede desarrollarse un descenso temporal de la presión sanguínea. En casos raros, puede producirse un colapso circulatorio como consecuencia de una caída profunda en la presión sanguínea. Si existe una caída remarcable en presión sanguínea durante la infusión ésta debe detenerse inmediatamente. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y dispepsia, cefaleas, vértigo y agitación.	
Incompatibilidades	Aciclovir, alprostadil, furosmida, heparina, manitol, nitroglicerina, nitroprusiato, sodio bicarbonato.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 104 de 153	

89.- LIDOCAINA 2%

Anestésico local - Antiarrítmico

Presentaciones AM: 100 mg/5ml

Indicaciones	Como anestésico local o regional. En el tratamiento de extrasístoles o taquicardia ventricular, fibrilación ventricular.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al principio activo. Bloqueo AV de II y III grado. Pacientes con síndrome de Adams - Stokes, síndrome de Wolff - Parkinson - White	
Almacenamiento	A temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	1 - 4 mg/ml. Máximo 8 mg/ml en infusión continua.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: Intraósea, S.C., endotraqueal.	
Velocidad de la administración	EV directa: 25 a 50 mg por min. No menos de 2-3 min. EV infusión continua: Velocidad de administración en mg/kg/min No exceder los 0,7 mg/kg/minuto o 50 mg/minuto.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar bradicardia, hipotensión, bloqueo cardiaco, arritmias, colapso cardiovascular, depresión respiratoria, apnea, letargia, coma, parestesia, agitación, euforia, alucinaciones, somnolencia, visión borrosa, cefalea, vómitos, rash. Puede provocar tromboflebitis en pacientes con infusiones continuas. Es compatible en la misma vía con amiodarona, atracurio, dobutamina, dopamina, epinefrina, fentanilo, labetalol, midazolam, morfina, norepinefrina, propofol, rocuronio, vecuronio. Usar con precaución en pacientes con disfunción hepática, insuficiencia cardiaca, hipoxia, depresión respiratoria, hipovolemia, shock, bloqueo incompleto, bradicardia.	
Incompatibilidades	Anfotericina B, cefazolina, fenitoina, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 105 de 153	

90.- LIDOCAINA HIPERBARICA 5%

Anestésico

Presentaciones AMP: 100mg/2ml

Indicaciones	Anestesia espinal inferior en obstetricia. Anestesia local por infiltración, anestesia regional, caudal, peridural, pélvica, troncal.	
Contraindicaciones	Bloqueo cardíaco completo, hemorragia grave, hipotensión grave o shock. Infección local en el lugar donde se piensa realizar la punción lumbar, septicemia. Antecedentes de sensibilidad a la lidocaína.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	No requiere.	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: No Otras vías: Raquídea	
Velocidad de la administración	La administración dependerá del objetivo terapéutico y del área a intervenir. Será definido por el anestesista a cargo	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Hipotensión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, vértigo, rash, bradicardia.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 106 de 153	

91.- LINEZOLID

Antibacteriano. Oxazolidinona

Presentaciones MTZ: 600 mg/300 ml

Indicaciones	Tratamiento de las infecciones de la piel y del aparato respiratorio causadas por bacterias Gram+, incluidas por enterococos resistente a vancomicina y Staphylococcus aureus resistente a metilicina.
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a linezolid o a algún componente de la formulación.
Almacenamiento	Temperatura ambiente y protegido de la luz
Sueros compatibles	No aplica
Reconstitución	No requiere
Dilución	No requiere
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 60 a 120 minutos. Si usa BIC la velocidad de administración en ML/HR
Dializable	No
Observaciones - RAM	Se puede observar hipertensión, dolor de cabeza, insomnio, mareos, fiebre, rash, náuseas, diarrea, vomito, constipación, pancreatitis, trombocitopenia, anemia, leucopenia, neutropenia, neuropatía periférica y óptica, alteración del gusto, decoloración de la lengua. La solución inyectable puede presentar una coloración ligeramente amarillenta que puede intensificarse con el tiempo sin afectar su potencia.
Incompatibilidades	Anfotericina-B, ceftriaxona, diazepam, fenitoina sodica, sulfametoxazol/trimetropin.

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 107 de 153	

92.- LORAZEPAM

Benzodiazepina

Presentaciones AM: 4 mg/2ml

Indicaciones	Tratamiento de corta duración de los trastornos de la ansiedad, como hipnótico en el tratamiento del insomnio y como anticonvulsante. También es utilizado por sus propiedades sedantes y amnésicas en pre-medicación.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Refrigerado y protegido de la luz.	
Sueros compatibles	SF, SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	0,4 mg/ml Habitual: 40 mg/ 100 ml 80 mg/200 ml 100 mg/ 250 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: 2 - 5 minutos EV infusión continua: La indicación se expresará en mg/kg/hora. Rango habitual: 0.01 a 0.1 mg/kg/hr	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	No usar si la solución presenta coloración o precipitado. Se puede producir paro cardíaco, hipotensión, bradicardia, colapso cardiovascular, confusión, disnea, ataxia, amnesia, flebitis, dolor en el sitio de inyección, visión borrosa, diplopía, disminución de la frecuencia respiratoria, laringoespasmo, dependencia física en uso prolongado. Utilizar con precaución en pacientes con falla hepática, falla renal, depresión del sistema nervioso central, hipotensión. Vigilar las soluciones para infusión por la posibilidad de precipitación espontánea. Como excipientes contiene polietilenglicol, alcohol benzílico y propilenglicol.	
Incompatibilidades	Cloxacilina, idarubicina, imipenem/cilastatin, omeprazol, ondasetron, rocuronio.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 108 de 153	

93.- MEROPENEM

Antibacteriano. Carbapenémico.

Presentaciones FAL: 500 mg
FAL: 1000 mg

Indicaciones	Indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, urinarias, intraabdominales, óseas y articulares, de piel y tejidos blandos, septicemias, meningitis u otra infección grave provocada por microorganismos resistentes a otros antibióticos.	
Contraindicaciones	Antecedentes de hipersensibilidad al meropenem y a otros carbapenémicos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF –SG5%	
Reconstitución	50 mg/ml	Estabilidad: T°A: 3 hrs R: 12 hrs
Dilución	2,5 - 10 mg/ml. No sobrepasar los 20 mg/ml. Habitual: 1 mg/100 ml 1 mg/ 250 ml	Estabilidad: T°A: 3 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: NO EV infusión intermitente: SI EV infusión prolongada: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 60 minutos. EV infusión continua: Velocidad de administración en mg/hr. Administrar en 3 a 4 hrs.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar hipotensión, dolor de cabeza, insomnio, agitación, rash, prurito, náuseas, vómitos, diarrea, leucopenia, neutropenia, flebitis, inflamación en sitio inyección. Se debe utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de epilepsia o episodios convulsivos, también debe administrarse con precaución en pacientes con función renal alterada, debido a que el 70% se elimina por esta vía, por tanto, también tienen más riesgo de producirse episodios convulsivos por acumulación del fármaco. Se recomienda monitorizar función renal, hepática y hematológica.	
Incompatibilidades	Anfotericina-B, diazepam, metronidazol.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 109 de 153	

94.- METADONA

Analgésico Narcótico. Opiode sintético

Presentaciones AM: 10 mg/2ml

Indicaciones	Analgesia (dolor agudo y crónico) y suplemento de la anestesia.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la metadona y cualquier componente de la formulación, depresión respiratoria, íleo paralítico.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	0,5 mg/ml	Estabilidad:
	Utilizarla inmediatamente después de preparada la dilución.	T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: SC	
Velocidad de la administración	EV directa: Inyectar sobre 1 min.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	La sobredosis es revertida con Naloxona. La metadona posee una vida media de eliminación prolongada, por lo que administrada en dosis múltiples se puede acumular. Náuseas, vómitos, constipación, somnolencia, embotamiento mental, hipotensión arterial, bradicardia e hipertensión intracraneal, insomnio, agitación, disfonía y miosis. Ocasionalmente puede provocar reacciones alérgicas. Depresión respiratoria, apnea.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 110 de 153	

95.- METAMIZOL

Analgésico – Antipirético - Antiinflamatorio

Presentaciones AM: 1 g/2 ml

Indicaciones	Dolores relacionados a intervenciones quirúrgicas, espasmos del aparato gastrointestinal, conductos biliares, riñones y vías urinarias. Estados febriles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a derivados pirazolónicos. Contraindicado en casos de porfiria aguda intermitente y deficiencia congénita de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF –SRL- SG5% (menos estable)	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	2 a 10 mg/ml 1000 mg/100 ml a 1000 mg/ 500 ml La concentración dependerá de la respuesta y los efectos adversos	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar en 60 minutos EV infusión continua: Velocidad de administración en ML/HR	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Se puede observar hipotensión, prurito, sudor, frío, náuseas, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad cutánea, en las mucosas oculares y en la región nasofaríngea, trombocitopenia, agranulocitosis. Puede alterar los exámenes de glucosa en orina. Se puede administrar la ampolla de metamizol ev vía oral para manejar el dolor en pacientes oncológicos. Usar con precaución en pacientes que estén recibiendo otros medicamentos que inducen agranulocitosis.	
Incompatibilidades	Ciclosporina, clorpromazina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 111 de 153	

96.- METILPREDNISOLONA SUCCINATO

Glucocorticoide - Antiinflamatorio Esteroidal - Inmunosupresor

Presentaciones FAL: 125 mg, 500 mg, 1000 mg

Indicaciones	Tratamiento de shock, insuficiencia adrenocortical, alergia, asma, dermatitis por contacto, urticaria, picaduras de insecto y en condiciones donde se requiere inmunosupresión.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5% - API	
Reconstitución	Con su disolvente (sistema act - o - vial). 5 cc API.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Dilución	Máxima concentración en bolo: 125 mg/ml. Máxima concentración en infusión: 2,5 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 48 hrs R: 48 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	Dosis menor o igual a 1,8 mg/kg o 125 mg/dosis bolo de 3 a 15 minutos. Dosis mayor o igual a 2 mg/kg o 250 mg/dosis administrar en 15 - 30 minutos. Dosis de 15 mg/kg o mayor a 500 mg/dosis administrar en más de 30 minutos. Dosis mayores a 15 mg/kg o mayor a 1g administrar en una hora.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar edema, hipertensión, intolerancia a la glucosa, hipokalemia, alcalosis, náuseas, vómito, espasmo muscular, síndrome de Cushing. Infecciones fúngicas sistémicas activas, infecciones virales activas. Utilizar con precaución en pacientes con herpes ocular simple, por riesgo de perforación corneal. Se debe monitorizar presión arterial, glucosa en sangre y electrolitos. Contiene alcohol bencílico. No confundir con la sal de acetato que se ocupa para administración intra-articular, intrasynovial, intrabursal o intralesional o como depósito.	
Incompatibilidades	Ciprofloxacino, docetaxel, etoposito, gemcitabina, gluconato de calcio, insulina regulr, ondasentron, paclitaxel, penicilina, propofol.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 112 de 153	

97.- METOCLOPRAMIDA

Bloqueante dopaminérgico – Antiemético - Estimulante peristáltico

Presentaciones AM: 10 mg/1 ml

Indicaciones	Profilaxis de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Tratamiento a corto plazo de pirosis y del vaciado gástrico retardado, secundarios a la esofagitis por reflujo.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF –SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	0,2 mg/ml Concentración máxima 5mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 48 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: 1 - 3 minutos, preferir infusión intermitente. EV infusión intermitente: 15 - 30 minutos (máximo 5 mg/minuto)	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Administrar con precaución en niños y adultos de edad avanzada, ya que presentan un mayor riesgo de reacciones extra piramidales, también pueden presentarse hipotensión, hipertensión, mareo, cefalea. Se requiere precaución cuando se administra a pacientes con insuficiencia renal, epilepsia, enfermedad de parkinson o antecedentes de depresión. La metoclopramida estimula la secreción de prolactina, por lo que puede provocar galactorrea o alteraciones relacionadas.	
Incompatibilidades	Ampicilina, anfotericina-B, calcio gluconato, cefepime, furosemida, penicilina G, propofol, sodio bicarbonato.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 113 de 153	

98.- METRONIDAZOL

Antibacteriano

Presentaciones MTZ: 500 mg/100 ml

Indicaciones	Tratamiento o prevención de septicemia, bacteriemia, infecciones intraabdominales postoperatorias, absceso pélvico, celulitis pélvica, tromboflebitis séptica, sepsis puerperal y en otras infecciones en las que se han identificado microorganismos anaerobios. Absceso hepático amebiano y otras formas graves de amebiasis intestinal y extra intestinal.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al metronidazol o a derivados nitroimidazoles.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	No aplica	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	No es necesario diluir la solución de metronidazol.	Estabilidad: T°A: 48 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar lentamente de 30 a 60 minutos.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Dolor de cabeza, tromboflebitis, neuropatía periférica, mareos, confusión, convulsiones, rash, sabor metálico, náuseas, leucopenia, diarrea. Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedades activas o crónicas severas del sistema nervioso central o periférico, debido al riesgo de agravamiento neurológico. Administrado en conjunto con disulfiram se pueden provocar episodios psicóticos. La orina puede tomar un color rojizo o marrón. Se recomienda proteger de la luz y conservar a temperatura ambiente, exposiciones cortas a la luz de una habitación no afectan la estabilidad del producto. No refrigerar porque puede precipitar.	
Incompatibilidades	Anfotericina-B, dopamina, meropenem.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 114 de 153	

99.- MIDAZOLAM

Benzodiazepina

Presentaciones	AM: 15 mg/3 ml AM: 50 mg/10 ml	
Indicaciones	Sedación pre quirúrgica o previa a procedimientos diagnósticos cortos (broncoscopio, gastroscopia, cistoscopia, cateterismo cardíaco), coadyuvante de la anestesia general. Sedación prolongada en unidad de cuidados intensivos en pacientes con ventilación mecánica.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a los benzodiazepinas, dolor incontrolable, depresión del SNC, shock, miastenia gravis, glaucoma de ángulo estrecho.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	1 mg/ml. La dilución es 1:1 Habitual: 100 MG/ 100 ML 200 MG/ 200 ML 250 MG/ 250 ML	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: V.O., endotraqueal	
Velocidad de la administración	EV directa: Diluir 1:1, administrar dosis indicada en 2 minutos según respuesta. EV infusión continua: La indicación se expresará en: mg/kg /hr. Rango habitual: 0.02 a 0.2 mg/kg/hr	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	El antagonista es el flumazenil. Se observa una disminución del volumen corriente o de la frecuencia respiratoria y apnea, variaciones de la presión arterial y bradicardia, alteraciones psicomotoras después de la sedación o anestesia con midazola las que pueden persistir durante períodos variables, temblor muscular, movimientos incontrolados del cuerpo, excitación, irritabilidad, hipotensión, somnolencia prolongada, vómitos, alucinaciones, confusión.	
Incompatibilidades	Albumina, anfotericina-B, ampicilina, cefazidima, cefuroxima, dexametasona, furosemida, hidrocortisona, imipenem, metotrexato, omeprazol, sodio bicarbonato, tiopental, trimetropin/sulfametoxazol.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 115 de 153	

100.- MILRINONA

Antiarrítmico - Inhibidor de la fosfodiesterasa

Presentaciones AM: 10 mg/10 ml

Indicaciones	Tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca congestiva grave. Shock cardiogénico por falla de bomba.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco o alguno de sus componentes.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	Diluir antes de administrar. 10mg en 50ml (200 mcg/ml)	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: No
Dilución	200 mcg/ml. Se pueden ocupar concentraciones de hasta 1000 mcg/ml, pero solo por vía venosa central. Habitual: 20 MG/250 ML	Estabilidad: T°A: 72 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	En infusión intermitente (carga) administrar lentamente en 10 min. EV infusión continua: 0,35 - 0,75 mcg/kg/minuto.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Administrar sólo en pacientes sometidos a un control hemodinámico continuo. Arritmia supra ventricular y ventricular, hipotensión, incremento de la frecuencia y dolor anginal, retención de fluidos, hipokalemia, hipertiroidismo, trombocitopenia	
Incompatibilidades	Bicarbonato de sodio, furosemida, imipenem.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 116 de 153	

101.- MORFINA

Analgésico Narcótico

Presentaciones	AM: 10 mg/1 ml AM: 20 mg/1 ml	
Indicaciones	Tratamiento moderado a severo en pacientes que requieran analgesia potente durante un tiempo prolongado.	
Contraindicaciones	Pacientes con hipersensibilidad reconocida al fármaco depresión respiratoria, en ausencia de un equipo de reanimación.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	0,5 - 5 mg/ml. La dilución es 1:2 Habitual: 50 mg/100 ml 100 mg/ 200 ml 125 mg/250 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: S.C.	
Velocidad de la administración	EV directa: Diluido 1:1, administrar bolo según respuesta en no más de 5 minutos EV infusión continua: La indicación se expresará en: mg/hora; o bien en MG/KG/HR Rango habitual: 0.8 a 10 mg/hr	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Naloxona es un fármaco antagonista de los receptores opioides. Se puede observar con mayor frecuencia constipación, retención urinaria, somnolencia, mareos, sedación, náuseas, vómitos, sudoración. En caso de intoxicación aguda los signos característicos son la depresión del SNC, que puede llegar a coma, depresión respiratoria y depresión cardiovascular (hipotensión). Usar con precaución en pacientes con pancreatitis (causa espasmo del esfínter de Oddi). El cambio de color (oscurecimiento) indica degradación. Es compatible en solución con dexmedetomidina, fentanilo, ketamina, lorazepam, midazolam, vecuronio. Usar con precaución en asma bronquial aguda o grave, sospecha de íleo paralítico. Insuficiencia renal.	
Incompatibilidades	Aminofilina, anfotericina-B, bicarbonato de sodio, fenobarbital, fluoracilo, heparina, petidina, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 117 de 153	

102.- NALOXONA

Antagonista de los Opiáceos

Presentaciones AM: 0,4 mg/1 ml

Indicaciones	Depresión respiratoria y del SNC inducida por opiáceos.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la naloxona.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	Bolo: 0,4 mg/ml Infusión continua: 2 mg en 50 ml (40 µg/ml) 2 mg en 500 ml (4 µg/ml)	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: S.C., intraósea	
Velocidad de la administración	EV directa: 30 segundos. EV infusión continua: 2.5 a 5 ml/h, 25 a 50 ml/h, (100 a 200 µg/hr).	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	El fármaco revierte los efectos de los analgésicos narcóticos, por lo tanto, se debe considerar administrar analgésicos no opioides para el tratamiento del dolor. Puede aparecer taquicardia ventricular o fibrilación en pacientes con irritabilidad ventricular preexistente. Además, taquicardia, hipotensión o hipertensión arterial, aumento de la sudoración, náuseas, vómitos y temblores. Todos estos efectos podrían estar relacionados con la reversión de los efectos opiáceos. Mantener monitorización cardiorrespiratoria continua. Deberá evaluarse la relación riesgo - beneficio en pacientes con irritabilidad cardíaca, dependencia o adicción a opiáceos en curso. En pacientes con sobredosis se debe establecer una ventilación asistida eficaz antes de administrarla, para evitar una reacción excesiva del sistema simpático.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos por la misma vía.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 118 de 153	

103.- MULTIVITAMINICO HIDROSOLUBLE

Presentaciones	FAL: Presentación niño y adulto Cada frasco de polvo liofilizado contiene Vitamina B1 2,5 mg, Vitamina B2 3,6 mg, Vitamina B6 4 mg, Nicotinamida 40 mg, Acido pantotenico 15 mg, Vitamina C 100 mg, Biotina 60 ug, Acido Folico 0,4 mg, Cianocobalamina 5 ug	
Indicaciones	Indicado como suplemento en nutrición para cubrir los requerimientos diarios de vitaminas hidrosolubles, cuando no se puede usar la vía oral	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes, intolerancia a la tiamina (B1), enfermedad de Leber o ambliopía toxica causada por el tabaco (por su contenido de vitamina B12).	
Almacenamiento	Almacenar a una temperatura inferior a 25°C. Proteger de la luz	
Sueros compatibles	API, glucosa sin electrolitos (5-70%), vitaminas liposolubles, lípidos (10-30%).	
Reconstitución	En 10 ml de suero o soluciones compatibles.	
Dilución	Cuando es reconstituida con vitaminas liposolubles, puede diluirse en 100 a 500 ml de SF o SG, según requerimientos de volumen. No usar Ringer Lactato	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar entre 4-6 hrs	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Reacciones alérgicas (rash, prurito), dolor de cabeza, agitación, mareos y ansiedad.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 119 de 153	

104.- MULTIVITAMÍNICO LIPOSOLUBLES

Presentaciones	Presentación para niños > 11 años y adultos Cada ml contiene Vitamina A 99 ug (330 UI) , vitamina D2 0,5 ug (20 UI), Vitamina E 0,91 ug (1 UI), Vitamina K1 15 mg	
Indicaciones	Indicado suplemento en nutrición para cubrir los requerimientos diarios de vitaminas liposolubles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la especialidad, hipervitaminosis, hipercalcemia, alergia conocida ala proteína de la soya y el huevo.	
Almacenamiento	Mantener a una temperatura inferior a 25°C. Proteger de la luz	
Sueros compatibles	Emulsiones lipídicas	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	La AM debe ser diluida antes de su uso a través de una emulsión lipídica, en el caso de usarse en conjunto con vitaminas hidrosolubles, puede usarse 100-500 ml de SF o SG, según requerimientos de volumen.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar entre 4-6 hrs	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	No debe ser administrado sin diluir. No se han descrito reacciones adversas. La vitamina D puede producir hipercalcemia, falla renal, calcificación en tejidos blandos, retraso del crecimiento, náuseas, constipación y pérdida de peso.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 120 de 153	

105.- NEOSTIGMINA

Colinérgico - Inhibidor de la colinesterasa reversible

Presentaciones AM: 0,5 mg/ml

Indicaciones	Tratamiento de la miastenia grave. Antidoto de la tubocurarina y de otros bloqueadores neuromusculares no despolarizantes.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco y en pacientes con obstrucción intestinal, urinaria y peritonitis.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	No es necesario diluir. Si se diluye: 0,167 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: SI Otras vías: S.C.	
Velocidad de la administración	EV directa: 1 mg/min	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar asistolia, bloqueo A - V, síncope, hiperperistaltismo, visión borrosa, diarrea severa, náuseas, vómitos, bradicardia, calambres, gastralgia, cansancio o debilidad no habituales, aumento de la secreción bronquial, sialorrea y lagrimeo no habitual, tremor, disartria, miosis, artralgia, paro respiratorio. La administración endovenosa debe ser lenta y disponiendo de atropina en forma inmediata para bloquear si fuera necesario las reacciones muscarínicas severas. Se debe ajustar en disfunción renal. Atropina y sulfato de magnesio se utilizan como antagonistas.	
Incompatibilidades	Sin datos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 121 de 153	

106.- NITROGLICERINA

Vasodilatador

Presentaciones FA: 50 mg/10 ml

Indicaciones	En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y crónica. Coadyuvante de la cirugía, para controlar la hipertensión pre o intraoperatoria, la isquemia miocárdica o la insuficiencia cardíaca. Hipertensión pulmonar.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad conocida a la nitroglicerina y a nitroderivados orgánicos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF – SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	50 - 100 mcg/ml. Máxima concentración 500 mcg/ml Habitual: 50 MG/100 ML 100 MG/ 200 ML 125 MG/250 ML	Estabilidad: T°A: 48 hrs R: 7 días
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: La indicación será en mcg/kg/minuto. Máxima velocidad 5 mcg/kg/minuto.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	No administrar en pacientes con hipotensión grave, hipovolemia, marcada anemia, insuficiencia cardíaca debida a obstrucción (incluida la pericarditis constrictiva), o presión intracraneal aumentada debida a un trauma en la cabeza o hemorragia cerebral. Se debe utilizar jeringas de polietileno o polipropileno, para evitar la acumulación de fármaco en las paredes de recipiente, recipientes de PVC absorben hasta el 80% de la dosis y si se ocupa este material la dosis debe ser ajustada. Se puede observar rubor facial, vértigo, taquicardia, cefalea. Dosis elevada causan vómitos, ansiedad, visión borrosa, hipotensión (que puede ser grave), síncope, cianosis y metahemoglobinemia. Es compatible por la misma vía con amiodarona, atracurio, cisatracurio, Dobutamina, dopamina, epinefrina, fentanilo, furosemida, labetalol, lidocaína, lorazepam, midazolam, milrinona, morfina, norepinefrina, pancuronio, propofol, ranitidina, remifentanilo, Nitroprusiato de sodio, tiopental, vecuronio.	
Incompatibilidades	Fenitoína, levofloxacino.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 122 de 153	

107.- NITROPRUSIATO

Vasodilatador

Presentaciones	AM: 50mg/2ml	
Indicaciones	Crisis hipertensivas. También utilizada para reducir la precarga y poscarga en la insuficiencia cardíaca grave, incluida la asociada a infarto de miocardio.	
Contraindicaciones	No debe administrarse en el tratamiento de la hipertensión compensadora, por ejemplo, en el shunt arteriovenoso o en la coartación de la aorta. Disminución de la perfusión cerebral.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente. Proteger de la luz.	
Sueros compatibles	SG5%	
Reconstitución	10 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Dilución	0,2 mg/ml. Máxima concentración: 1 mg/ ml Habitual: 50 MG/ 250 ML	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: la indicación será en mcg/kg/minuto. Máximo 8 - 10 mcg/kg/minuto.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Nitroprusiato debe administrarse mediante bombas de infusión y líneas de infusión fotosensibles. Evitar extravasación. La solución de nitroprusiato es muy sensible a la luz. En presencia de luz, una elevada proporción del medicamento (20 % o más) será degradado al cabo de 4 horas. Desechar cualquier solución que presente coloración naranja, marrón oscuro o azul. El color azul indica una degradación total del suero. Tampoco administrar si se presenta turbidez o precipitación opaca. Para evitar que la solución se degrade debe mantenerse resguardada de la luz, envolviendo el suero con una cubierta protectora, así pueden ser estables al menos en 24 horas. Puede ocasionar hipotensión excesiva, intoxicación por acumulación de cianuro y tiocianatos, en especial en pacientes con disfunción renal. Se usa como antídoto el tiosulfato sódico 10% AM de 5 ml (100 mg/ml). La Infusión IV puede provocar náuseas y vómitos, cefalea, mareo, inquietud, sudoración, palpitaciones, dolor retro esternal, dolor abdominal y espasmos musculares, que disminuyen reduciendo la velocidad de infusión, también se ha descrito metahemoglobinemia. Otros efectos adversos son trombocitopenia y flebitis.	
Incompatibilidades	No se recomienda mezclar con otros medicamentos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 123 de 153	

108.- NOREPINEFRINA

Vasopresor - Inótropo

Presentaciones	AM: 4 mg/4 ml	
Indicaciones	Tratamiento del shock distributivo asociado a resistencia vascular sistémica baja y resistente a reposición de volumen. Hipotensión severa.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SG5%. No ocupar suero fisiológico por reportes contradictorios de estabilidad.	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	40 mcg/ml Habitual: 4 mg/100 ml 8 mg/ 200 ml 10 mg / 250 ml En situaciones de restricción de volumen usar hasta 160 mcg/ml 16 mg/100 ml 32 mg /200 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No Soluciones concentradas a 160 mcg/ml tiene estabilidad de 6 hrs.
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión continua: La indicación se expresará en: mcg/Kg/min. Rango habitual: 0.01 a 1.5 mcg/kg/min	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar cefaleas, ansiedad, dificultad respiratoria, hipertensión, taquicardia, bradicardia, arritmia, dolor de pecho, diaforesis, contracción uterina, ftofobia, insuficiencia renal, necrosis local por extravasación. Debe ser administrado por CVC, se conecta al lumen proximal (depende de la institución) Mantener con monitorización electrocardiográfica y línea arterial en UCI. Si la solución adquiere una coloración café no utilizar, ya que hay una alta probabilidad que se degrade por oxidación. No es estable en soluciones alcalinas.	
Incompatibilidades	Aminofilina, bicarbonato de sodio, fenobarbital, furosemida, insulina regular, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 124 de 153	

109.- OLIGOELEMENTOS

Terapia de oligoelementos

Presentaciones	AM: 10 ml Cada ampolla contiene: Cloruro de Zinc 10,5 mg, Cloruro de Cobre dihidratado 1,02 mg, Cloruro de Manganeso tetrahidratado 198 mcg, Cloruro de Cromo hexahidratado 53,3 mcg, Cloruro Ferrico Hexahidratado 5,40 mg. Selenio de Sodio Anhidro 173 mcg, Molibdato de Sodio Dihidratado 48,5 mcg, Ioduro de Potasio 166 mcg, Fluoruro de Sodio 2,10 mg. pH = 2,5 Osmolalidad = 3100 mOsm/Kg agua
-----------------------	---

Indicaciones	Indicado en nutrición parenteral para satisfacer los requerimientos basales a moderadamente aumentados de oligoelementos.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a los principios activos, afección con obstrucción biliar total, enfermedad de Wilson, hemocromatosis. Niños menores de 15 kg de peso corporal.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	Añadida a sueros compatibles en volumen de 100-250 ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	2 – 4 hrs	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	No administrar sin diluir. Uso catéter venoso central	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 125 de 153	

110.- OCTREOTIDE

Inhibidor de la secreción de la hormona de crecimiento.

Presentaciones AM: 0,1 mg/1 ml

Indicaciones	Tratamiento de la diarrea asociada a quimioterapia. Tratamiento quilotorax Hemorragias por varices esofágicas.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad	
Almacenamiento	Refrigerado entre 2-8° C	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	Dejar a temperatura ambiente durante 30-60 minutos antes de diluir. Diluir el contenido de la ampolla en 50-200 ml de SF o SG5%.	Estabilidad: T°A: 24 hrs en SG5% y 96 hrs en SF R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: SC	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar mediante infusión de 15-30 minutos	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Puede provocar diarrea, dolor abdominal, náusea, estreñimiento, flatulencia, dispepsia, vómitos, hinchazón abdominal, esteatorrea, deposiciones líquidas, coloración en las heces, cefalea, mareo, hipotiroidismo, disfunción tiroidea, coleditiasis, colecistitis, depósitos biliares, hiperbilirrubinemia, hiper e hipoglucemia, niveles elevados de transaminasas, prurito, exantema, disnea, bradicardia.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 126 de 153	

111.- OMEPRAZOL

Antiulceroso – Antiácido - Inhibidor de bomba de protones

Presentaciones FAL: 40 mg

Indicaciones	Está indicado para el tratamiento de úlcera duodenal, úlcera gástrica, enfermedad ulcerosa péptica con histología antral o cultivo positivo para <i>Helicobacter pylori</i> , esofagitis por reflujo, síndrome de Zollinger - Ellison, pacientes con riesgo de aspiración del contenido gástrico durante anestesia general (profilaxis de aspiración). Profilaxis de úlceras por estrés.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%.	
Reconstitución	4 mg/ml 10 ml de suero por 40 mg	Estabilidad: T°A: 4 hrs R: No
Dilución	0,04 mg/ml 40 mg/100 ml	Estabilidad: T°A: 4 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos EV infusión intermitente: Administrar de 30 a 60 minutos	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar raramente erupción y prurito. En casos aislados, fotosensibilidad, eritema multiforme, artralgia, debilidad muscular y mialgia, cefalea, raramente mareos, parestesia, somnolencia, insomnio, vértigo, confusión mental reversible, agitación, depresión y alucinaciones, sobre todo en pacientes con enfermedad severa, diarrea, constipación, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, estomatitis y candidiasis gastrointestinal, incremento de las enzimas hepáticas, encefalopatía en pacientes con enfermedad hepática severa preexistente, hepatitis con ictericia o no y falla hepática. Leucopenia y trombocitopenia, angioedema, fiebre, broncoespasmo y nefritis intersticial, incremento del sudor, edema periférico. No debe utilizarse si se observan partículas en la solución reconstituida. Su cambio de color es sinónimo de descomposición.	
Incompatibilidades	No administrar medicamentos en la misma vía, si es necesario usarla la vía, lavarla al término de la infusión.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 127 de 153	

112.- ONDANSETRON

Antiemético

Presentaciones AM: 8 mg/4 ml

Indicaciones	Prevención de las náuseas y los vómitos asociados con los ciclos iniciales y repetidos de quimioterapia. Nauseas asociada a postoperatorio.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al medicamento.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	EV directa: No diluir. Infusión intermitente: 4 -8 mg en 100 ml Infusión continua: 24 mg en 250 ml	Estabilidad: T°A: 12 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos Infusión intermitente: Administrar de 30 a 60 minutos Infusión continua: 0,2 - 0,5 mcg/kg/min.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar constipación, rash cutáneo, ocasional y transitorio aumento de la aspartato transaminasa (AST) y alanina transaminasa (ALT), cefaleas, reacciones extrapiramidales, visión borrosa transitoria, hipopotasemia y rubor facial, taquicardia. Administrar lentamente porque provoca hipotensión transitoria.	
Incompatibilidades	Aciclovir, ampicilina, aminofilina, furosemda, ganciclovir, lorazepam, metilprednisolona, piperacilina/tazobactam	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 128 de 153	

113.- OXITOCINA

Ocitocico inductor del parto

Presentaciones AM: 5 UI/ml

Indicaciones	Inducción de parto, atonía e hipotonía uterina. Retención placentaria. Control de la hemorragia post-parto.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco. No debe administrarse durante periodos prolongados en pacientes con inercia uterina resistente a oxitocina, toxemia preeclámpsica grave o trastornos cardiovasculares graves. Parto vaginal.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente. No congelar	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere	
Dilución	10 – 40 UI/1000 ml	Estabilidad: T°A: 6 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	La dosis y velocidad está determinada por la respuesta uterina y el objetivo terapéutico Inducción del parto: Adm una velocidad inicial de 1 -2 mili unidades/min, ir aumentando 1 - 2 mili unidades cada 15 - 60 min, hasta una velocidad máxima de 20 miliunidades/min. La velocidad se puede reducir en cantidades similares una vez establecido el parto. Tratamiento hemorragia post-parto: 10 UI a una velocidad de 20-40 miliunidades/min.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Hematoma pélvico o hemorragia post-parto, alergia o anafilaxia generalizada, arritmias cardíacas o contracciones ventriculares prematuras, hipotensión seguida de hipertensión y taquicardia refleja, rotura uterina, náuseas, vómitos.	
Incompatibilidades	Norepinefina	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 129 de 153	

114.- PARGEVERINA 5 MG/METAMIZOL 2G

Antiespasmódico - Anticolinérgico

Presentaciones AM: 5 MG/ML

Indicaciones	Antiespasmódico destinado al tratamiento de aquellos síndromes viscerales, agudos o crónicos, cuyo principal componente es el espasmo de la musculatura lisa. Espasmos gastrointestinales de las vías biliares, de las vías urinarias y aparato genital femenino. Tratamiento sintomático de las náuseas y vómitos.	
Contraindicaciones	Uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, estenosis pilórica, íleo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave y miastenia gravis.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	EV directa: 20 ml de suero Infusión intermitente: 100 -250 ml de suero	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: SI EV infusión intermitente: SI EV infusión continua: No IM: SI	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos Infusión intermitente: Administrar de 30 a 60 minutos	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se han observado reacciones como: Somnolencia; resequedad de boca y estreñimiento. Con dosis muy superiores puede presentarse retención urinaria, visión borrosa, taquicardia, cefaleas, mareos, insomnio, reacciones alérgicas.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 130 de 153	

115.- PARACETAMOL

Analgésico - Antipirético

Presentaciones FA: 500 mg/50 ml
FA: 1000 mg/100 ml

Indicaciones	Dolor moderado y fiebre a corto plazo, cuando existe necesidad urgente o no son posibles otras vías.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a paracetamol, insuficiencia hepatocelular grave, hepatitis vírica.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	No requiere. Sólo se diluye si la dosis es menor a la entregada por el vial o según los requerimientos clínicos. Dilución 1:1 (1 mg/ml) Si la solución diluida no se utiliza inmediatamente, no debe guardarse durante más de 6 horas	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar de 15 a 30 minutos	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Hipotensión, hepatotoxicidad, erupción cutánea, alteraciones hematológicas, hipoglucemia.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 131 de 153	

116.- PENICILINA G SODICA

Antibacteriano

Presentaciones FAL: 1.000.000 U.I.
FAL: 2.000.000 U.I.

Indicaciones	Infecciones debidas a microorganismos sensibles.	
Contraindicaciones	Individuos con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	API, SF - SG5%	
Reconstitución	Reconstituir con 5 ml solvente	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	50.000 – 100.000 U.I./ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: Si	
Velocidad de la administración	Infusión intermitente: Administrar de 60 a 120 minutos	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Tromboflebitis, confusión, anemia hemolítica, mioclonia, nefritis intersticial, reacciones de hipersensibilidad, anafilaxia. La administración EV muy rápida puede producir convulsiones.	
Incompatibilidades	Anfotericina-B, clorpromazina, citarabina, metilprednisolona, vancomicina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 132 de 153	

117.- PETIDINA

Analgésico Narcótico

Presentaciones AM: 100 mg/2 ml

Indicaciones	Tratamiento del dolor postoperatorio y neoplásico. En el preoperatorio como sedante y agente que facilita la anestesia.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	E.V. directa: Concentración ≤ 10 mg/ml. E.V. intermitente o infusión continua: Concentración de 1 mg/ml.	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: S.C.	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos (preferir la intermitente). Infusión intermitente: Administrar de 15 a 30 minutos	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	La sobredosis es revertida con Naloxona. La administración rápida puede producir un incremento en el riesgo de efectos adversos, principalmente depresión respiratoria, apnea, hipotensión. Se puede observar náuseas, vómitos, mareos, palpitación, bradicardia y prurito. Produce menos constipación y retención urinaria que la morfina. El cuadro de sobredosis se caracteriza por excitación, alucinaciones, convulsiones y midriasis. Medicamento sometido a control de estupefacientes.	
Incompatibilidades	Aciclovir, aminofilina, anfotericina-B, cefepime, ciclosporina, clorpromazina, fenitoína sódica, fenobarbital, furosemida, heparina sódica, imipenen, morfina, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 133 de 153	

118.- PIPERACILINA - TAZOBACTAM

Antibacteriano. Asociación de derivado de penicilina con inhibidor de betalactamasas.

Presentaciones	FAL: Piperacilina 4 g/tazobactam 0,5 g.	
Indicaciones	Tratamiento de infecciones polimicrobianas severas en que se sospecha presencia de microorganismos aerobios y anaerobios.	
Contraindicaciones	Antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas o inhibidores de betalactámicos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	API, SF - SG5%, RL	
Reconstitución	20 ml solvente compatible.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 48 hrs
Dilución	EV directa: 20 ml solvente EV infusión intermitente: 4,5 gramos (1 frasco) en 100 ml EV infusión continua: De 1 a 4 frascos en 100 ml de solvente (200 mg/ml)	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 7 días
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3 - 5 minutos (preferir intermitente). EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 20 – 30 min. EV infusión continua. Se debe infundir de manera continua por 3 a 4 hrs.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Diarrea, constipación, náuseas, vómitos, insomnio, dolor de cabeza, rash, dispepsia, leucopenia, trombocitopenia, hipertensión, hipotensión, edema, agitación, confusión, broncoespasmo, hipokalemia, eosinofilia. Observar signos de anafilaxis durante los primeros minutos tras la administración. Administrar con una hora de separación con aminoglicósidos para disminuir sobrecarga renal y evitar incompatibilidades.	
Incompatibilidades	Aciclovir, anfotericina B, amikacina, clorpromazina, cisplatino, dacarbazina, daunorubicina, dobutamina, doxorubicina, doxiciclina, droperidol, fluconazol, ganciclovir, gemcitabina, gentamicina, haloperidol, idarubicina, mitoxantrona, ondansetron, vancomicina.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 134 de 153	

119.- PIRIDOXINA

Vitamina B6

Presentaciones AM: 100 mg/1 ml

Indicaciones	Prevención y tratamiento de la hipovitaminosis B6. En la neuritis periférica asociada a tratamientos con isoniazida o hidralazina. Útil en náuseas y vómitos producidos por radiación. Manejo de status epiléptico.	
Contraindicaciones	Antecedentes de hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	10 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos IM: Inyección profunda.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Puede producir dolor de cabeza, parestesia, neuropatía sensorial, náuseas, disminución sérica de ácido fólico. Se han pesquisado convulsiones a dosis muy grandes de piridoxina. La administración E.V. debe ser lenta. No administrar por vía E.V. a pacientes con cardiopatías.	
Incompatibilidades	No mezclar con otros medicamentos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 135 de 153	

120.- PROPRANOLOL

Betabloqueador – Antihipertensivo - Antiarrítmico

Presentaciones AM: 1 mg/1 ml

Indicaciones	Tratamiento de las arritmias cardíacas (supra ventriculares), taquicardias, hipertensión, profilaxis de la migraña.	
Contraindicaciones	En pacientes con bloqueo AV y bradicardia, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, hipersensibilidad al propranolol y betabloqueadores.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	EV directa: 1mg/10ml, también puede usarse sin diluir. EV infusión intermitente: 10 -20 mg/100 ml Concentración máxima 1 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No	
Velocidad de la administración	Administrar en infusión rápida a una velocidad de 1mg/min o lentamente en una infusión de 30 min.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Hipotensión, falla cardíaca congestiva, bradicardia, insomnio, hipoglicemia, broncoespasmo, agranulocitosis, extremidades frías, náuseas, vómitos y diarrea, las que se evitan reduciendo la dosis y luego aumentándola gradualmente. Si se presenta respuesta vagal excesiva, puede corregirse con 1 - 2 mg de atropina vía E.V. La solución se descompone rápidamente en soluciones alcalinas. Debe considerar el riesgo beneficio en los siguientes casos: pacientes asmáticos, portadores de enfermedades bronquiales obstructivas, diabetes, hipotiroidismo, depresión, síndrome de Raynaud.	
Incompatibilidades	Anfotericina-B, bicarbonato.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 136 de 153	

121.- PROPOFOL

Anestésico de corta duración

Presentaciones

AM: 1% 20 ml
FA: 1% 50 ml
FA: 2% 50 ml

Indicaciones	Inducción y mantención de la anestesia general. Sedación en ventilación mecánica	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al propofol, a la soya y al huevo.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente. No refrigerar	
Sueros compatibles	SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	2 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 6 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	<u>Inyección repetida de bolos:</u> Si se emplea una técnica de inyección repetida de bolos, se pueden administrar incrementos de 25 mg a 50 mg, según la necesidad clínica. Cuando se emplea como sedante para pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica, se recomienda administrar en infusión continua. Si necesita aumentar rápidamente la profundidad de la sedación, podrá administrarse un bolo de 10 a 20 mg en conjunto con la infusión continua <u>EV infusión continua:</u> La indicación será en mg/kg/hr La velocidad de infusión debe ajustarse según la profundidad de la sedación requerida, pero regímenes del orden de 0.3 a 4.0 mg/kg/hora deben lograr una sedación satisfactoria.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Usar venas de gran calibre o de preferencia CVC y preparar con la máxima asepsia. Con el fin de reducir el dolor causado por el propofol, se puede administrar lidocaína antes de la administración o mezclada con él. Se puede observar bradicardia, hipotensión, ardor, dolor o prurito en el sitio de la inyección, apnea, erupciones, reacciones anafilácticas, contracción auricular prematura, síncope, hipertensión, parestesia, hipersalivación, mialgia, prurito. La orina pudiera tomar un color verde. No usar si se sospecha de una solución contaminada o si hay evidencia de separación de fases de la emulsión o decoloración.	
Incompatibilidades	No mezclar con productos sanguíneos ni con otros medicamentos por la misma vía o en una mezcla.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 137 de 153	

122.- PROTAMINA

Hemostático - Antagonista de la heparina.

Presentaciones FA: 50 mg/5 ml

Indicaciones	Inactivación de la heparina en caso de hemorragias debidas a su administración intravenosa o subcutánea. Inactivación de la heparina usada en la circulación extracorpórea y en hemofiltración.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la protamina.	
Almacenamiento	Mantener bajo 25°C	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	Se puede administrar sin diluir o diluir con 25 - 50 ml de suero	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Subcutánea: No	
Velocidad de la administración	EV directa: La velocidad es de 10 mg (1 ml) en 1-3 minutos Infusión intermitente o continua: Velocidad de administración en ML/HR. Administrar en 10 minutos no exceder los 5 mg/minuto.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Los principales efectos incluyen hipotensión arterial durante la administración, alergia, náuseas, vómitos, hipertensión pulmonar. Estas reacciones aparecen en forma más frecuente con las infusiones rápidas (mayores de 5 mg/minuto). <u>Neutralización heparina E.V.</u> La dosis de protamina es determinada por la dosis más reciente de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular: 1 mg de protamina neutraliza 100 unidades de heparina, 1 mg de enoxaparina y 100 unidades de dalteparina. Dosis máxima: 50 mg. <u>Sobredosis de heparina. E.V.</u> Debido a que las concentraciones sanguíneas de heparina decrecen rápidamente, la relación de heparina/protamina va cambiando en el tiempo.	
Incompatibilidades	Medios de contraste, betalactámicos. Se recomienda no administrar con otros productos por la misma vía.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 138 de 153	

123.- RANITIDINA

Antagonista de los receptores H2 de histamina.

Presentaciones AM: 50 mg/2ml

Indicaciones	Tratamiento de úlcera duodenal y gástrica. En la profilaxis de úlcera por estrés, en las hemorragias digestivas y el reflujo gastroesofágico.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la ranitidina.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	EV directa: No exceder 2,5 mg/ml, 20 ml suero. EV infusión intermitente o continua: Concentración usual de 0,5 mg/ml, 100 ml de suero.	Estabilidad: T°A: 48 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar en al menos 5 minutos (no exceder de una velocidad de 10 mg/minuto). EV infusión intermitente: Administrar en 15 a 30 minutos.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Se puede observar cefaleas, erupción cutánea transitoria, vértigo, constipación, náuseas. En algunos casos se observaron reacciones de tipo anafiláctico (edema angioneurótico, broncoespasmo), bradicardia, taquicardia, confusión mental, ginecomastia, constipación, trombocitopenia, hepatitis, dolor articular. Preferir la administración intermitente para reducir el riesgo de hipotensión y bradicardia.	
Incompatibilidades	Anfotericina-B, atracurio, cefazolina, ceftazidima, cefuoxima, insulina, midazolam, fenobarbital.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 139 de 153	

124.- SODIO BICARBONATO 2/3 MOLAR

Alcalinizante - Reposición electrolitos

Presentaciones	MTZ: 250 ml Cada 100 ml aporta 5,6 g de bicarbonato de sodio, con 666,7 meq de sodio y 666,7 meq de bicarbonato. Osmolaridad 1333 mOsm/l
Indicaciones	Tratamiento de acidosis metabólicas agudas y graves, ya sean causadas por una pérdida de bicarbonato (diarrea grave, acidosis tubular renal) o por acumulación de un ácido como ocurre en la cetoacidosis o en situaciones de acidosis láctica; para alcalinizar la orina en el tratamiento de intoxicaciones agudas de ciertos fármacos (barbitúricos, salicilatos) con el fin de disminuir la reabsorción renal del tóxico o para disminuir los efectos nefrotóxico que se pueden producir en las reacciones hemolíticas.
Contraindicaciones	Hipersensibilidad, alcalosis metabólicas y respiratorias, pacientes hipocalcémico, pacientes con pérdidas excesivas de cloruro por vómitos y en pacientes con riesgo de alcalosis hipoclorémica inducida por diuréticos, acidosis respiratoria en la que hay retención primaria de CO ₂
Almacenamiento	Temperatura ambiente.
Sueros compatibles	No aplica
Reconstitución	No requiere.
Dilución	No requiere.
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No
Velocidad de la administración	EV infusión continua: Según valores de bicarbonato en gasometría y requerimiento específicos del equipo médico, la indicación será en ml/hr.
Dializable	No
Observaciones - RAM	Alcalosis metabólica, hipocalemia, hipocalcemia, acidosis láctica, hipernatremia, estado hiperosmolar, cambios de humor, irritabilidad, hipertonia, hemorragia cerebral, arritmia, hipotensión, hipoxia, diarrea, debilidad muscular, fatiga, edema, necrosis, úlcera y descamación.
Incompatibilidades	Amiodarona, anfotericina-B, cefotaxima, ciprofloxacino, dobutamina, dopamina, epinefrina, imipenem, labetalol, magnesio sulfato, meropenem, midazolam, morfina, norepinefrina, ondasentron, succinilcolina.

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 140 de 153	

125.- SUCCINILCOLINA

Relajante Muscular despolarizante

Presentaciones FAL: 100 MG

Indicaciones	Relajante muscular esquelético, para procedimientos de corta duración o intubación endotraqueal.	
Contraindicaciones	Antecedentes de hipersensibilidad a la succinilcolina. Hipertermia maligna, miopatías de la musculatura esquelética. Glaucoma. Heridas penetrantes oculares. No debe ser utilizado en pacientes con quemaduras graves, traumas severos, denervación extensa del músculo esquelético o en otras patologías que puedan afectar el nivel de potasio.	
Almacenamiento	Almacenar a no mas de 30°C	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	2 ml de suero compatible	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	1 - 2 mg/ml a goteo continuo 250 mg/ 250 ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: 2,5 mg/min La cantidad requerida por minuto variara con la respuesta individual y el grado de relajación requerido.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Fasciculaciones musculares, dolor postoperatorio, rigidez muscular, hiperkalemia, bradicardia, hipotensión, incremento de la presión intraocular, intracraneal e intra-abdominal, rash, salivación excesiva, broncoespasmo, mioglobulinuria, mioglobinemia. El bloqueo neuromuscular se potencia con algunos antibióticos que poseen acción bloqueante neuromuscular (aminoglicósidos, clindamicina, colistin), anestésicos locales, altas dosis de tiopental, ketamina, fentanilo, etomidato y propofol, diuréticos de asa, magnesio, litio, hipotermia, hipokalemia y acidosis respiratoria. Se debe tener precaución al indicarlo en pacientes con potasio sobre 5,5 mEq/l.	
Incompatibilidades	Bicarbonato de sodio, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 141 de 153	

126.- SULFATO DE MAGNESIO 25 %

Electrolito

Presentaciones AM: 5 ml
Cada ampolla contiene a 1,25 g de sulfato de magnesio.
Cada ml contiene 2,03 mEq de sulfato y 2,03 mEq de magnesio.

Indicaciones	Tratamiento y prevención de hipomagnesemia. Tratamiento de torsades de pointes, arritmias atribuidas a hipomagnesemia. Prevención y tratamiento de las convulsiones en pre-eclampsia y eclampsia severa.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco, bloqueo cardíaco y daño renal severo.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente. No refrigerar (puede precipitar).	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	100 a 500 ml de suero	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente o continua: Velocidad de administración en ml/hr. No exceder 1 mEq/kg/hora (125 mg/kg/hora de sulfato de magnesio o 120 mg/minuto). En situaciones especiales puede ser infundido en 15 - 20 minutos.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Se puede observar hipotensión y asistolia al administrarlo rápidamente, depresión del sistema nervioso central, diarrea, somnolencia, rubor, hipotermia, hipotonía, disminución de los reflejos, ritmo cardíaco y respiratorio, bloqueo completo cardíaco, parálisis respiratoria. En pacientes sensibles puede producir una ligera sensación de calor durante la inyección.	
Incompatibilidades	Anfotericina-B, cefepime, ciprofloxacino, clindamicina, dobutamina, bicarbonato de sodio.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 142 de 153	

127.- TERLIPRESINA

Análogo hormonal de Vasopresina

Presentaciones FAL: 1mg

Indicaciones	Tratamiento de las hemorragias digestivas por rotura de varices esofagogástricas. Tratamiento de urgencia del síndrome hepatorenal de tipo 1	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al fármaco. Embarazo (provoca contracciones uterinas y descenso del flujo sanguíneo en el útero).	
Almacenamiento	Temperatura ambiente	
Sueros compatibles	SF	
Reconstitución	10 a 20 ml de suero	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	No requiere.	
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar en 1 minuto.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	La inyección debe ser administrada exclusivamente por vía intravenosa para evitar la necrosis local que puede producirse por extravasación del producto. Administrar bajo monitoreo simultáneo de frecuencia cardíaca y presión sanguínea. Se han observado cefalea, arritmia ventricular y supraventricular, bradicardia, signos de isquemia en el ECG, hipertensión, hipotensión, vasoconstricción periférica, isquemia periférica, palidez facial, hioetensión arterial, cólicos abdominales transitorios, diarrea transitoria, palidez, calambres abdominales (en mujeres).	
Incompatibilidades	Incompatible con soluciones alcalinas.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 143 de 153	

128.- TIAMINA

Vitamina hidrosoluble. Vitamina del grupo B1

Presentaciones	AM: 30 mg /1 ml	
Indicaciones	Tratamiento y prevención de los estados de deficiencia de tiamina. Encefalopatía y neuritis. Situaciones frecuentemente acompañadas por deficiencias de vitamina B1 y que requieren suplementación incluyen: consumo excesivo de alcohol, estado nutricional deteriorado.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad. La tiamina se excreta a la leche materna. No debe utilizarse durante la lactancia	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	Concentración máxima 1,2 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos Infusión intermitente: Administrar de 15 a 30 minutos Infusión continua: Administrar de 60 a 120 minutos	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Reacciones alérgicas y anafilácticas, reacciones de hipersensibilidad con sus respectivas manifestaciones clínicas y de laboratorio que incluyen síndrome asmático, reacciones leves a moderadas en la piel y/o tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y/o sistema cardiovascular.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 144 de 153	

129.- TIGECICLINA

Antibacteriano de amplio espectro

Presentaciones FAL: 50 mg

Indicaciones	Tratamiento de infecciones complicadas de piel e infecciones intra-abdominales complicadas causadas por organismos susceptibles.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a tigeciclina o tetraciclinas.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	5 ml de suero compatible	Estabilidad: T°A: 6 hrs R: No
Dilución	1 mg/ml La solución diluida presenta un coloración anaranjada	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: 48 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: No IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar de 30 a 60 minutos	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Puede producir prolongación de TTPA y TP, hipoglucemia, hipoproteinemia, mareo; flebitis, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dispepsia, anorexia, aumento en suero de AST, ALT, hiperbilirrubinemia, prurito, erupción cutánea, problemas de cicatrización, reacción en el lugar de inyección cefalea; aumento de amilasa en suero y del BUN. Su uso prolongado puede provocar colitis pseudomembranosa por C.difficile.	
Incompatibilidades	Incompatible con anfotericina B, clorpromazina, metilprednisolona y voriconazol.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 145 de 153	

130.- TRAMADOL

Analgésico Opiáceo

Presentaciones AM: 100 mg/2 ml

Indicaciones	Alivio del dolor moderado a intenso.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad conocida a Tramadol o a cualquiera de sus excipientes, en intoxicaciones agudas originadas por alcohol, hipnóticos, analgésicos, opioides o psicotrópicos, así como en pacientes bajo tratamiento con inhibidores de la MAO o que los han recibido en el transcurso de las últimas dos semanas. Tramadol no debe ser utilizado como tratamiento del síndrome de abstinencia.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	10 mg/ml	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Dilución	1,2 mg/ml Habitualmente 300 mg/ 250 ml	Estabilidad: T°A: 48 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: Si	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos Infusión intermitente: Administrar de 30 a 60 minutos Infusión continua: Administrar de 10 a 40 ml/h, según respuesta.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	En caso de intoxicación se utilizará la Naloxona como antídoto. Se han observado reacciones tipo Mareos, cefaleas, confusión, somnolencia, náuseas, vómitos, estreñimiento, sequedad bucal, sudoración, fatiga.	
Incompatibilidades	Sin datos	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 146 de 153	

131.- VANCOMICINA

Antibacteriano. Glicopéptido.

Presentaciones FA: 500mg, 1000 mg

Indicaciones	Se usa principalmente en el tratamiento de infecciones severas causadas por organismos susceptibles, en pacientes que no responden a penicilinas o cefalosporinas o cuando la infección es resistente a otro agente anti-infeccioso.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a glicopéptidos o a teicoplanina.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	50 mg/ml	Estabilidad: T°A: 14 días R: 14 días
Dilución	4 a 10 mg/ml Habitual: 1g /100 ml 1g / 250 ml	Estabilidad: T°A: 7 días R: 14 días
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: Oral, intratecal	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Infundir 1000 mg en 60 minutos. EV infusión continua: Según indicación. Velocidad de administración en ml/hr. En ambos esquemas no exceder de 10 mg/minuto.	
Dializable	Si	
Observaciones - RAM	Se puede observar hipotensión, taquicardia, flebitis, urticaria, náuseas, fiebre, eosinofilia, ototoxicidad, nefrotoxicidad, erupción cutánea macular, escalofríos. La administración demasiado rápida puede dar lugar al síndrome del "hombre rojo", con caída de la presión arterial y eritema en cara, cuello, pecho, y extremidades superiores. En caso de presentarse debe disminuir la velocidad de infusión. Evitar la extravasación durante su administración, ya que es muy irritante para los tejidos. La monitorización mediante niveles es una herramienta muy útil para evaluar la seguridad y efectividad del producto. Es muy importante ser rigurosos con los tiempos y ritmos de administración del antibiótico, así como con el registro de los horarios de extracción de muestras (guiarse por protocolos). La administración intratecal solo se debe realizar con suero fisiológico y a una concentración de 7,5 mg/ml.	
Incompatibilidades	Albumina, anfotericina-B, cefepime, dexametasona, fenitoina, fenobarbital, heparina, idarrubicina, omeprazol.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 147 de 153	

132.- VECURONIO

Agente bloqueador neuromuscular No despolarizante. Relajante musculo liso

Presentaciones FA: 10 mg/2,5 ml

Indicaciones	Bloqueo muscular coadyuvante de la anestesia general, para facilitar la intubación traqueal y para proveer relajación del musculo esquelético durante la cirugía o ventilación mecánica.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad al vecuronio.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%- SRL	
Reconstitución	1 - 2 mg/ml	Estabilidad: T°A: No R: No
Dilución	2mg/ml. Infusión continua máximo 1mg/ml.	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: 1 - 3 minutos. EV infusión continua: 0,5 - 2 mcg/kg/minuto (hasta 10 mcg/kg/minuto ocasionalmente).	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Se observa enrojecimiento, hipotensión, taquicardia, bradicardia, arritmia, flebitis, broncoespasmo, hipoxemia, erupción, urticaria, eritema, bloqueo neuromuscular prolongado, mareos, espasmo muscular y apnea. El uso de vecuronio puede producir alteraciones electrolíticas (hiponatremia, hipocalcemia, hipokalemia, hipomagnesemia), falla renal, falla hepática. No se debe administrar intramuscular por ser muy irritante. Para evitar miopatía del paciente critico se deben realizar periodos de ventana, cuando se maneje en infusión continua (se puede utilizar con monitorización neuromuscular).	
Incompatibilidades	Anfotericina B, diazepam, tiopental.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 148 de 153	

133.- VERAPAMILO

Antagonista del calcio - Antiarrítmico de clase IV

Presentaciones AM: 5 mg/2 ml

Indicaciones	Arritmia supra ventricular y tratamiento de la hipertensión aguda y severa.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a verapamilo o cualquier componente de la formulación; insuficiencia cardíaca grave (a menos que secundaria a una taquicardia supra ventricular susceptibles de verapamilo); hipotensión severa o shock cardiogénico; síndrome del seno enfermo (excepto en pacientes con un marcapasos ventricular artificial en funcionamiento); segunda o bloqueo AV de tercer grado (excepto en pacientes con un marcapasos ventricular artificial funcionamiento), aleteo auricular o fibrilación, taquicardia ventricular.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	EV directa: 5 mg/10 ml Infusión intermitente o continua: 0.5 mg/1 ml.	Estabilidad: T°A: 24 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar lentamente en 3-5 minutos Infusión intermitente: Administrar de 30 a 60 minutos Infusión continua: La indicación será en mcg/kg/min. El rango es de 1 a 5 mcg/Kg/min.	
Dializable	No	
Observaciones - RAM	Bradicardia, bloqueo auriculoventricular, agravación de la insuficiencia renal y asistolia transitoria. Estreñimiento, náuseas, hipotensión, mareo, sofocos, cefaleas, fatiga, disnea y edema periférico.	
Incompatibilidades	Albumina, anfotericina-B, ampicilina, propofol, sodio bicarbonato, sulfametoxazol/trimetropin.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 149 de 153	

134.- VORICONAZOL

Antifúngico. Derivado azólico

Presentaciones FAL: 200 mg

Indicaciones	Tratamiento de aspergilosis invasiva, tratamiento de infecciones severas invasivas por <i>Cándida</i> resistente a fluconazol (incluyendo <i>C. krusei</i>); otras infecciones micóticas graves causadas por hongos susceptibles.	
Contraindicaciones	En pacientes con hipersensibilidad al fármaco.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	10 mg/ml.	Estabilidad: T°A: 4 hrs R: No
Dilución	0,5 - 5 mg/ml.	Estabilidad: T°A: No R: 24 hrs
Administración	EV directa: No EV infusión intermitente: Si EV infusión continua: NO IM: No	
Velocidad de la administración	EV infusión intermitente: Administrar lentamente en 1 - 2 horas no sobrepasando una velocidad de infusión de 3 mg/Kg/hora.	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Se pueden observar arritmias (síndrome QT largo y en menor frecuencia torsades de pointes), alucinaciones visuales y auditivas en los primeros días del tratamiento, alteraciones electrolíticas, especialmente de calcio, magnesio y potasio que pueden aumentar la incidencia de arritmias. También se han descrito alteraciones de la visión en tratamientos prolongados (> 28 días) manifestadas principalmente como alteraciones del campo visual y cambios en la percepción del color. Sinusitis, agranulocitosis, pancitopenia, trombocitopenia, leucopenia, anemia, edema periférico, hipoglucemia, hipopotasemia, hiponatremia; depresión, alucinación, ansiedad, insomnio, agitación, estado confusional, cefalea, convulsión, síncope, temblor, hipertonia, parestesia, somnolencia, mareo, alteración visual, hemorragia retiniana; arritmia supra ventricular, taquicardia, bradicardia, hipotensión, flebitis, dificultad respiratoria, síndrome de sufrimiento respiratorio agudo, edema pulmonar, diarrea, vómitos, dolor abdominal, náuseas.	
Incompatibilidades	Soluciones alcalinas, productos sanguíneos y otros medicamentos en la misma vía.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 150 de 153	

135.- URAPIDIL

Antihipertensivo. Bloqueador receptores alfa-adrenérgicos

Presentaciones AM:100 mg/20 ml, equivalente a 5 mg/ml

Indicaciones	Indicado en el tratamiento de la crisis hipertensiva, hipertensión severa o resistente a tratamiento e hipertensión peri y postoperatoria, especialmente en neurocirugía.	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a Urapidil, estenosis del istmo de la aorta o shunt arteriovenos.	
Almacenamiento	Temperatura ambiente.	
Sueros compatibles	SF - SG5%	
Reconstitución	No requiere.	
Dilución	0,5 mg/ml 250 mg /250 ml	Estabilidad: T°A: 48 hrs R: No
Administración	EV directa: Si EV infusión intermitente: No EV infusión continua: Si IM: No Otras vías: No	
Velocidad de la administración	EV directa: Administrar bolos en 20 segundos EV infusión continua: La indicación será en mg/hr. Rango habitual 12 – 120 mg/hr	
Dializable	Sin datos	
Observaciones - RAM	Hipotensión, trastornos cardíacos y náuseas. Si el paciente ha recibido previamente otros agentes antihipertensivos, no debe utilizarse Urapidil hasta que haya transcurrido el tiempo necesario para que la acción de dicha medicación se haya establecido. Se recomienda no usar el medicamento por más de 7 días, debido a que los estudios toxicológicos están limitados a ese tiempo. En el tratamiento de la emergencia hipertensiva se ajustará la dosis de manera que la disminución de la presión arterial no exceda el 25% del nivel original en el plazo de una hora de instaurado el tratamiento, una disminución demasiado abrupta en la presión puede conducir a una isquemia miocárdica, cerebral o renal.	
Incompatibilidades	No debe mezclarse con soluciones alcalinas para inyección o infusión, puesto que puede producirse enturbiamiento o floculación debido a las propiedades ácidas de la solución de la inyección.	

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 151 de 153	

7. Distribución.

- Formato Impreso en carpeta de acreditación: no aplica.
- Formato Digital: A través de correo electrónico, distribuido a todos los servicios clínicos de hospitalización en sus distintas áreas, pabellones quirúrgicos, recuperación y servicio de urgencia adulto e infantil.
- Disponible en página web del Hospital: www.hhha.cl

8. Registro.

- Ficha clínica del paciente
- Tarjetas de medicamentos

9. Control de cambios.

DOCUMENTO MODIFICADO		
Nº Versión	Fecha Elaboración	Motivo de la Revisión

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 152 de 153	

10. Anexos.

Anexo 1: Fórmulas de cálculo

- ml/hr $\frac{\text{Volumen Total}}{\text{Tiempo para pasar (hr)}}$
- Gotas/min $\frac{\text{Volumen (ml)} \times \text{factor gotas (gotas/ml)}}{\text{Tiempo (hrs)} \times 60 \text{ (minutos)}}$

- De ml/hr hacia mcg/min

$$\frac{\text{Dosis (mcg)}}{\text{Volumen (ml)}} \times \frac{\text{ml/hr}}{60} = \text{mcg/min}$$

- De mcg/kg/hr hacia ml/hr:

$$\frac{\text{Indicación en mcg} \times \text{Peso en Kg} \times \text{Volumen Total}}{\text{Concentración de la droga en mcg}} \times 60 = \text{ml/hr}$$

		Código	MN-SDG-0420
		Versión	01
		Fecha	Abril 2020
		Vigencia	Abril 2025
		Página 153 de 153	

Anexo 2: Equivalencias

I.- Equivalencias de masa y volumen.

1 kg: 1000 g

1 g: 1000 mg

1 mg: 1000 mcg

1 ug: 0.001 mg

1 mcg: 1 ug

1 mg: 1000 ug

Ng: Milmillonésima parte de un gramo, es decir, un nanogramo corresponde a 1/1.000.000.000 gramo

1 U.I.: Unidad Internacional difiere de una sustancia a otra.

1 lt: 1000 ml

1 dl: 100 ml

II. - Equivalencias de electrolitos

Producto	Volumen (ml)	Concentración (mg/ml)		Concentración (mEq/ml)		Concentración (mmoles/ml)	
Bicarbonato de Sodio 8,4%	10	Bicarbonato= 66,01	Sodio= 22,99	Bicarbonato= 1	Sodio=1	Bicarbonato=1	Sodio=1
Bifosfato de Potasio 15%	10	Bifosfonato= 106,9	Potasio=43,1	Bifosfonato=1,1	Potasio=1,1	Bifosfonato= 1,1	Potasio=1,1
Cloruro de Potasio 10%	10	Cloruro=47,56	Potasio=52,44	Cloruro=1,34	Potasio=1,34	Cloruro=1,34	Potasio=1,34
Cloruro de Sodio 10%	10	Cloruro=60,66	Sodio=39,34	Cloruro=1,71	Sodio=1,71	Cloruro=1,71	Sodio=1,71
Cloruro de Sodio 0,9 %	10	Cloruro=5,46	Sodio=3,54	Cloruro=0,15	Sodio=0,15	Cloruro=0,15	Sodio=0,15
Gluconato de Calcio 10%	10	Gluconato=43,52	Calcio=8,94	Gluconato=0,47	Calcio=0,47	Gluconato=0,94	Calcio=0,93
Sulfato Magnesio 25%	5	Sulfato=97,48	Magnesio=24,66	Sulfato=2,03	Magnesio=2,03	Sulfato=4,06	Magnesio=4,06